

Prescrição PS Fast

Receitas prontas para PS / APS. Lembrar: alergias · AINE → rim · corticoide → HAS e DM. Doses = ponto de partida adulto; validar peso, função renal/hepática, gestação e protocolo local.

■ Geral / Crítico

Anafilaxia · CID T78

Exame físico

REG/MEG, ansioso.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Pele: urticária/angioedema, edema de lábios/face. VAS: [estridor, edema de glote]. AP: sibilos difusos, tir

■ PS / Sala — Prescrição — PS

ADRENALINA (1mg/ml): 0,3 - 0,5 MG IM - REPETIR 5/5 MIN POR MAIS 2X, SE NECESSÁRIO

SALA DE EMERGENCIA

MOV

DIETA ZERO

RINGER LACTATO 500ML EV

HIDROCORTISONA (100mg/frasco): 300MG + SF 0,9% 10 ML

■ PS / Sala — Refratariedade

- ADRENALINA 0,1ML + 9ML SF EV EM BOLUS

- ADRENALINA 10 AMP + 90ML SG5% EM BIC - COMEÇAR COM 4ML/HORA EM ACESSO CENTRAL

■ Casa — Se broncoespasmo

NEBULIZAÇÃO: SALBUTAMOL (5mg/ml) 10-20 gotas + 3ml SF 0,9%

Ataque Isquemico Transitório · CID G45

■ ECG, USG cervical, Angio TC/ RNM, eco transtorácico (ambulatorialmente ou internado)

Calcular ABCD2 score

ABCD2 ≥ 4

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril. (assintomático no momento – déficit já resolvido).

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Neuro: Glasgow 15, SEM déficits focais no exame atual. ACV: RCR, avaliar sopro carotídeo, ritmo (FA?). Calc

■ Casa — ABCD2 < 4

AAS 100MG

02 CP AO DIA

■ Internação — INTERNAÇÃO

AAS 100MG

02 CPS, DOSE DE ATAQUE. SEGUIDO POR 01 CP/ DIA

CLOPIDOGREL 75MG

04 CPS, DOSE DE ATAQUE. SEGUIDO POR 01 CP AO DIA (POR 21 DIAS)

DIPIRONA 1G EV DE 4/4 HORAS

METOCLOPRAMIDA 10MG EV 8/8 HORAS

OMEPRAZOL 20-40MG VO/EV PELA MANHA

Dengue · CID A90

■ Colher NS1 em até 5 dias de sintomas, de preferência no 3º.

- Repouso - Aumentar ingestão de líquidos - Não utilizar anti-inflamatórios (Ex: Ibuprofeno, Nimesulida, Cetoprofeno, etc) - Retornar ao serviço médico caso apresente sinais de alarme (dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosas). Grupo C/D HEMOGRAMA, ALBUMINA, TRANSAMINASES, PCR. Se necessário: RX TORAX, USG ABDOMINAL Aqui: 10ml/kg SF0,9% EV Reavaliar Mais 10ml/kg SF0,9% EV Paciente em uso de AAS: hemograma diário. Suspender se plaquetas <30 000

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., hidratado.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C. (PA deitado e em pé).

Prova do laço: [negativa]. Pele: [exantema?], sem petéquias/sangramentos. Abdome: fígado não palpável, indo

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Soro de reidratação oral ----- 1 caixa

Diluir 1 sachê em 1L de água filtrada e tomar pelo menos 1L ao longo de um dia. Alternar com água filtrada.

1) Dipirona 500mg ----- 40 comprimidos

Tomar 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre por 5 dias

OU 1)PARACETAMOL 500mg ----- 40 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas se dor ou febre por 5 dias

3)Ondansetrona 08 mg

Tomar 1 comprimido de 8/8h, se náusea ou vomito por 5 dias

■ Casa — Prescrição — Casa

DIPIRONA 1G -----

TOMAR 01CP DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE

DESCLORATADINA 5MG
TOMAR 01 CP 1X AO DIA, SE COCEIRA
DRAMIN B6
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, SE NÁUSEA, VOMITO OU TONTURA
SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL ----- 4 ENVELOPES
DILUIR 1 ENVELOPE EM 1 LITRO DE AGUA E BEBER DURANTE O DIA. BEBER MAIS 3 LITROS DE OUTROS LÍQUIDOS (ÁGUA, SUCO, ETC).

Enjoo / Náuseas

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., hidratado.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Abdome: flácido, indolor, RHA+, sem defesa. Sem sinais de desidratação. [Investigar causa: gestação, medica

■ Casa — Prescrição — Casa

1. DRAMIN B6 ----- 1 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H SE NAUSEAS/VÔMITOS
OU 1. ONDANSETRONA 4MG ----- 1 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H SE NAUSEAS/VÔMITOS
OU 1. PLASIL 10 MG ----- 1 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H SE NAUSEAS/VÔMITOS

Febre Maculosa · CID A77

Exame físico

REG, febril, toxemiado.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Pele: exantema maculopapular em punhos/tornozelos com progressão centrípeta (inclui palmas/plantas). Mialgi

■ Casa — Prescrição — Casa

DOXICILINA 100MG -----
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS OU POR ATÉ 7 DIAS APÓS PARAR A FEBRE
DIPIRONA 50MG -----
TOMAR 01 CP DE 6/6H, SE DOR OU FEBRE
DRAMIN B6 -----
TOMAR 01 CP DE 8/8H, SE NAUSEA OU VOMITO

■ Internação — Se internação

SF 0,9% 30ML/KG EV EM 24H
DOXACILINA 100MG EV DE 12/12 HORAS, MANTER POR 3 DIAS APÓS TERMINO DE FEBRE
DIPIRONA 1G EV 4/4H, SE DOR OU FEBRE
BROMOPRIDA 10MG/2ML EV DE 8/8H, SE NAUSEA OU VOMITO
SOLICITAR: HEMOGRAMA, NA, K, CREATININA, TGP, TGO

Intoxicação Exógena · CID Y19.9

■ MOV (O2 se Sat <94%)

Exame físico

[Nível de consciência ___], Glasgow ___.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Pupilas [mióticas/midriáticas]. Pele [seca/sudoreica]. Toxíndrome: [colinérgica/anticolinérgica/opioide/sim

■ PS / Sala — Prescrição — PS

ABCD
Ligar Ceatox 0800 014 8110
Hemograma, EAS, função renal, Na, K, Ca, Mg, gasometria arterial, ECG
Descontaminação
CARVÃO ATIVADO 1G/KG (máx 50g) - em até 2 horas da ingestão. VO ou SNE.
Manter: 50G 4/4 HORAS
Se AAS, tricíclicos, fenobarbital: BICARBONATO DE SÓDIO 1-2 MEQ/KG - na ampola de 8,4% 1ml = 1 mEq - fazer em infusão aberta em bolus. Após: 150 ml de Bicarbonato + 1L de soro glicosado 5% - infusão continua de 100 200ml/h. Acompanhar com EAS, Ca e K.
Se organofosforados/carbamatos: ATROPINA 2MG EV A CADA 5 MINUTOS ate sumir os roncos na ausculta
Se opióides: NALOXONA 0,4 MG EV, REPETIR A CADA 3 MINUTOS, AUMENTANDO A DOSE (0,8/2/4/6)
Se benzodiazepínicos: FLUMAZENIL 0,1MG EV BOLUS
Se cocaína, anfetamina, crack: DIAZEPAM EV
Se paracetamol: N-ACETILCISTEINA 140MG/ KG. Manter: 17 doses 70mg/kg 4/4 horas
No olho: 1-2 gotas de colírio anestésico + lavagem com SF

Intubação Orotraqueal (70 kg)

Exame físico

Paciente com indicação de via aérea definitiva.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Glasgow __, esforço respiratório [___], SatO2 __%. Preditores de VA difícil (LEMON/Mallampati). Pré-oxigenaç

■ PS / Sala — Prescrição — PS

- MOV
- Preparo: checar aspirador, separar materiais (laringoscopia 3 ou 4, tubo 7 ou 7,5,ambu, guedel seringa 20ml, drogas, posicionar
- Pré-oxigenação: mascara não reinalante ou bolsa-valvula 10 a 12 L/min por 3 a 5 minutos
- Analgesia: Fentanil (2mg/ml - 10ml): 3 a 4ml EV em bolus lento
- Hipnótico: Etomidato (10ml): 10ml EV (0,2 a 0,4 mg/kg) OU Quetamina (10ml): 3-4ml OU propofol (20ml): 10-20ml OU Midazolam (10ml): 3-4ml
- Bloqueador neuromuscular: Succinilcolina (10mg/ml): misturar o pó em 10ml SF, aspirar tudo (1 a 1,5mg/kg) Rocuronio (5ml): 7ml EV
- IOT: checar ausculta
- Ventilador: Modo VCV FiO2 100% PEEP: 6 a 10 FR: 16 Tinsp: 1,0 VC (4-6ml/kg predito): 420 ml
- Sedação em BIC: Fentanil 4 amp + 500ml SF em 10 ml/h E Midazolam 4 amp + 500ml SF em 10ml/h

Leptospirose

■ - Repouso - Hidratação - Evitar uso de Aspirina

HEMOGRAMA, UREIA, CREATININA, NA, K, TGO, TGP, BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES, VHS, PCR, URINA I, CPK PCR LEPTOSPIROSE / IGM IGG LEPTOSPIROSE

Exame físico

REG, febril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Mialgia intensa (panturrilhas), sufusão conjuntival. [Icterícia rubínica]. Avaliar oligúria/LRA, sinais hemolíticos

■ Casa — Prescrição — Casa

DOXICILINA 100MG ----- 014 CPS
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS
DIPIRONA 500MG
TOMAR 01 A 02 CPS DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE
BROMOPRIDA 10MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, SE NÁUSEA OU VÔMITO

Picada de Aranha-Marrom · CID W57

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Lesão: placa marmórea com halo isquêmico central em [local], dor local. Avaliar forma cutânea vs cutâneo-visceral

■ PS / Sala — Grave

5 AMP SAAR EV (em até 36h da picada)
PREDNISONA 20MG
TOMAR 02 CPS PELA MANHA POR 5 DIAS

■ PS / Sala — Muito grave

10 AMP SAAR EV
PREDNISONA 20MG
TOMAR 02 CPS PELA MANHA POR 5 A 7 DIAS

■ Casa — Leve – moderado

PREDNISONA 20MG
TOMAR 02 CPS PELA MANHA POR 5 DIAS

Picada de Escorpião (Acidente Escorpiônico) · CID T63

■ limpar com água e sabão, compressa morna _____
INFILTRAÇÃO ANESTÉSICO SEM VASOCONSTRICTOR OBSERVAÇÃO POR 4 HORAS COMPRESSA MORNA LOCAL
INTERNAÇÃO

Exame físico

[BEG/agitado por dor].
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Local da picada: dor intensa, [parestesia]. Avaliar sinais sistêmicos (sudorese, sialorreia, vômitos, taquicardia)

■ PS / Sala — Quadros moderados

MONITORIZAÇÃO
SORO ANTIESCORPIÔNICO (5ml): 3 AMP EV
Se não tiver o soro: SORO ANTIARACNÍDICO 3 AMP EV
OBSERVAÇÃO POR 24 HORAS

■ PS / Sala — Quadros graves

SORO ANTIESCORPIÔNICO (5ml): 6 AMP EV
Se não tiver o soro: SORO ANTIARACNÍDICO 6 AMP EV

Picada de Jararaca (Acidente Botrópico) • CID T63

Exame físico

[BEG].
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Local: edema, dor, equimose, [bolhas/necrose]. Sangramento local/gengivorragia. Avaliar tempo de coagulação

■ PS / Sala — Prescrição — PS

SORO ANTIBOTRÓPICO (5mg/ml)
Leve: 2-4 AMP EV
Moderado: 4-8 AMP EV
Grave: 12 AMP EV

■ PS / Sala — Se infecção secundária

CLORANFENICOL 50-100 MG/KG/DIA VO/EV 6/6 HORAS
DIPIRONA 1G EV 6/6 HORAS
MANTER DIURESE 30-40 ML/ HORA
ELEVAÇÃO DO MEMBRO
Se complicações: FASCIOTOMIA / DESBRIDAMENTO DE AREAS NECROSADAS / DRENAGEM ABSCESSO

Relação Desprotegida / Violência Sexual (PEP)

■ Teste rápido HIV, sífilis, hepatite B e C. Checar vacina hepatite B.
PEP (até 72 horas)

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Exame conforme protocolo de violência sexual (preservação de evidências se aplicável). Genital/anal: [lesões]

■ Casa — Prescrição — Casa

TENOFOVIR/LAMIVUDINA 300MG + 300MG
TOMAR 01 CP AO DIA POR 28 DIAS
DOLUTEGRAVIR 50MG
TOMAR 01 CP AO DIA POR 28 DIAS
LEVONORGESTREL 1,5mg (até 72 horas)
TOMAR 01 CP VO
PENICILINA G BENZATINA
2,4 MILHOES UI IM - 1,2 MILHÃO EM CADA GLUTEO
CEFTRIAXONA 500MG IM
AZITROMICINA 500MG 02 CPS
METRONIDAZOL 400MG 05 CPS VO
HEMATOLOGIA

Sepse • CID A41

■ Suspeita: SOFA e NEWS - solicitar hemograma, creatinina, bilirrubina
- Gasometria, Lactato e Culturas
- Antibiótico: ligar CCIH do hospital para perguntar

Exame físico

REG/MEG, toxemiado.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Nível de consciência [rebaixado?]. Perfusão: TEC ___s, extremidades [frias/quentes], livedo. Buscar foco (pu

■ PS / Sala — Alta suspeição

- Cristaloide 30ml/kg em 3h - alíquotas de 500ml
- Se necessário: Noradrenalina (1mg/ml) 20ml + 80ml SG 5% EV em BIC (começar com 10ml/h)
- Dipirona (500mg/ml): 1-2g 6/6h
- Bromoprida (10/2ml): 10mg EV 8/8h
- Omeprazol (40mg/ml): 20-40mg EV/VO pela manha
Ao internar: hemocultura e urocultura.

■ Cabeça / Neuro

AVC Hemorrágico (AVCH) • CID I64

■ Dextro, hemograma, coagulograma, betaHCG, ECG, TC crânio sem contraste
INTERNAÇÃO UTI + AVALIAÇÃO NEUROCIRURGIAO.

Exame físico

[Rebaixamento], Glasgow ____.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Neuro: déficit focal [____], [rigidez de nuca se HSA], pupilas [____]. NIHSS ____.
Cefaleia súbita intensa/vômito

■ PS / Sala — Prescrição — PS

DIETA ZERO
SF 0,9% OU RINGER LACTATO 20-30 ML/KG/DIA
DIPIRONA 1G EV DE 4/4 HORAS
METOCLOPRAMIDA 10MG EV 8/8 HORAS

OMEPRAZOL 20-40MG VO/EV PELA MANHA

■ PS / Sala — Crise convulsiva

DIFENIL-HIDANTOINA (50MG/ML)

Ataque: 15 mg/kg EV

Manutenção: 100MG EV DE 8/8H

Manter PAS = 140 (hemorragia intraparenquimatosa) e PAS < 160mmHg (hemorragia subaracnoide).

NITROPRUSSIATO DE SÓDIO (25MG/ML) 50MG + 250ML SG 5%(= 200MCG/ML) – INICIAR COM 0,5 MCG/KGMIN.

■ Casa — Se hemorragia subaracnoide

NIMODIPINA 60MG 4/4 HORAS POR 21 DIAS

SUSPENDER ANTIAGREGANTES E ANTICOAGULANTES.

REVERTER ANTICOAGULAÇÃO (olhar whitebook).

AVC Isquêmico (AVCI) • CID I64

■ Dextro, hemograma, coagulograma, betaHCG, ECG, TC crânio sem contraste

INTERNAÇÃO UTI

Exame físico

[Alerta/rebaixado], Glasgow ____.

SSVV: PA ____/____ | FC ____ | FR ____ | SatO2 ____% | Tax ____°C.

Neuro: déficit focal – [hemiparesia/disartria/desvio de rima/afasia/hemianopsia]. NIHSS ____.

■ PS / Sala — Prescrição — PS

DIETA ZERO

SF 0,9% OU RINGER LACTATO 20-30 ML/KG/DIA

INSULINA REGULAR 2-4 UI SC (manter glicemia entre 140 e 180)

DIPIRONA 1G EV DE 4/4 HORAS

METOCLOPRAMIDA 10MG EV 8/8 HORAS

OMEPRAZOL 20-40MG VO/EV PELA MANHA

O2 SE SAT <94%

Controle PA

Manter ≤ 220x120 em qualquer situação

Iniciar trombólise apenas se ≤185x110 – manter abaixo de 180x110

NITROPRUSSIATO DE SÓDIO (25MG/ML) 50MG + 250ML SG 5%(= 200MCG/ML) – INICIAR COM 0,5 MCG/KG/MIN

Trombólise (< 4,5h): checar contraindicações

ALTEPLASE (50MG/ML) 0,9 MG/KG (MÁX 90 MG): 10% DA DOSE EM BOLUS, RESTANTE EM INSUFAO LENTA EM 1 HORA – ACESSO PERIFÉRICO

AAS 100MG: 02 CPS AO DIA (se trombólise, aguardar 24 para iniciar)

HEPARINA NÃO FRACIONADA 5000 SC 8/8H OU ENOXAPARARINA 40MG SC 24/24H (se trombólise, aguardar 24 para iniciar).

Cefaleia • CID R51

■ Paciente refere cefaleia há _____. Nega início súbito da dor, nega pico de intensidade em segundos, nega pior cefaleia da vida, nega trauma craniano recente, nega febre, nega rigidez de nuca, nega vômitos persistentes, nega síncope, nega convulsões, nega alteração visual, nega diplopia, nega alteração da fala, nega confusão mental, nega fraqueza, nega parestesias, nega desequilíbrio, nega dificuldade para deambular, nega uso de anticoagulantes, nega mudança do padrão habitual da cefaleia.

#MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO: NEGA

#COMORBIDADES PRÉVIAS: NEGA

#ALERGIAS: NEGA ALERGIAS MEDICAMENTOSAS CONHECIDAS.

#EXAME FÍSICO:

Bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril

Neuro: GLASGOW 15, sem sinais meníngeos, sem déficits focais.

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., orientado.

SSVV: PA ____/____ | FC ____ | FR ____ | SatO2 ____% | Tax ____°C.

Neuro: Glasgow 15, pupilas isofotorreagentes, sem déficits focais, sem rigidez de nuca. Marcha e fala preservadas.

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Dipirona 500mg ----- 40 comprimidos

Tomar 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor por 5 dias

2) Naproxeno 550mg ----- 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas se dor. Uso por até 5 dias.

ou

2)Cetoprofeno 100mg ----- 1 caixa

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas se dor. Uso por até 5 dias.

3) ONDANSETRONA 4MG ----- 1 CAIXA

TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H SE NAUSEAS/VÔMITOS

4) Sumax 50mg ----- 1 caixa

Tomar 1 comprimido ao iniciar sintomas de enxaqueca para abortar crise. A dose pode ser repetida, se necessário.

Cefaleia Pós-Raqui · CID 074.5

■ Refratário

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Cefaleia POSTURAL (piora ao sentar/levantar, alivia deitado), após raqui/punção. Neuro: sem déficits focais

■ PS / Sala — Refratário

AQUI: RINGER LACTATO 2500ML EV EM 24H

■ Casa — Prescrição — Casa

DIPIRONA + MUCATO DE ISOMETEPTENO + CAFEINA 300/30/30MG-----

TOMAR 02 CP DE 6/6 HORAS, POR 3 DIAS

OU PARACETAMOL + CAFEINA 500/65MG -----

TOMAR 02 CP DE 6/6H POR 3 DIAS

■ Casa — Prescrição — Casa

AMITRIPTILINA 25MG -----

TOMAR 01 CP A NOITE POR 3 NOITES

Cefaleia Tensional · CID R51

■ Profilaxia

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., orientado.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Dor em aperto/pressão bilateral, leve-moderada, sem náusea. Neuro: sem déficits, sem rigidez de nuca. Tensão

■ Casa — Prescrição — Casa

PARACETAMOL 750MG

TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR

E/OU

DICLOFENACO 50MG

TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS

■ Casa — Prescrição — Casa

AMITRIPTILINA 10MG

TOMAR 01 A 05 CPS A NOITE

Crise Convulsiva · CID R56

Exame físico

Pós-ictal: sonolento, [confuso], Glasgow em recuperação.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Sem sinais de trauma cranioencefálico. Neuro: [Todd?], sem rigidez de nuca. Glicemia capilar ___. Avaliar mo

■ PS / Sala — Prescrição — PS

- MOV

- Se HGT < 60: glicose hipertônica 50%

- Diazepam 10mg EV - repetir no máximo 2x / Se paciente SEM acesso: Midazolam 15 mg IM

- Não melhorou: Fenitoína 1 amp + 250ml de SF 0,9% EV em BIC - correr em 30 minutos

- Considerar IOT se não houver melhora

- Procurar focos: TC crânio, eletrólitos, hemograma, PCR, Urina I

- Avaliação Neurologia

Encefalopatia Hipertensiva · CID I67.4

■ Excluir IAM, AVC, Dissecção aorta, trauma

Exame físico

[Confuso/rebaixado], Glasgow ___.

SSVV: PA muito elevada ___/___ | FC ___.

Neuro: cefaleia, [alteração visual], sem déficit focal fixo (diagnóstico de exclusão – afastar AVC). Fundo

■ PS / Sala — Prescrição — PS

ECG, RX TÓRAX, URINA 1, CREATININA, ELETRÓLITOS, MARCADORES CARDIACOS (S/N), TC CRÂNIO (S/N)

DIETA ZERO

RINGER LACTATO 20ML/KG EV EM 24 HORAS, SE NECESSÁRIO

Abaixar 15% da PA na 1º hora: NITROPRUSSIATO DE SÓDIO: 1 AMP (50MG/2ML) + 250ML SG5% - INICIAR INFUSÃO COM 5-10ML/ HORA

DIPIRONA 1G EV DE 6/6HORAS, SE DOR

BROMOPRIDA 10NG EV DE 8/8 HORAS, SE NAUSEA E VÔMITO

OMEPRAZOL 40MG EV 1X PELA MANHÃ

Enxaqueca · CID G43

■ EVITAR OPIÓIDES
PROFILAXIA

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., [fotofobia presente].
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Neuro: Glasgow 15, sem déficits focais, sem rigidez de nuca, pupilas isofotorreagentes.

■ PS / Sala — Crise leve

DIPIRONA 1 AMP EV OU
PROFENID 1 AMP EV

■ PS / Sala — Crise moderada

CLORPROMAZINA 1 AMP EV E/OU
DRAMIN 1 AMP EV OU BROMOPRIDA 1 AMP EV E/OU
Estado migranoso
DEXAMETASONA 1 AMP EV LENTO

■ Casa — Prescrição — Casa

SUMATRIPTANO 50MG
TOMAR 01 A 02 CP, DOSE ÚNICA, SE CRISE DE ENXAQUECA
OU NAPROXENO 500MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 3 DIAS
OU IBUPROFENO 400MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 3 DIAS

■ Casa — Prescrição — Casa

PROPRANOLOL 40MG
TOMAR 02 CPS 1X AO DIA
OU METOPROLOL 25MG
TOMAR 04 CP 1X AO DIA
OU AMITRIPTILINA 25MG
TOMAR 01 CP 1X AO DIA
OU ACIDO VALPROICO 250MG
TOMAR 01 CP 3X AO DIA

Meningite Bacteriana · CID G00.9

■ Se meningococo, profilaxia para contactuantes:

Exame físico

REG/MEG, toxemiado, febril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Rigidez de nuca, Kernig/Brudzinski [positivos]. Glasgow ___. [Petéquias/púrpura = meningococcemia]. Fotofobia

■ PS / Sala — Prescrição — PS

HEMOGRAMA, UREIA, CREATININA, COAGULOGRAMA, HEMOCULTURA, LACTATO, GLICOSE, LÍQUOR, TC (S/N)
RINGER LACTATO OU SF 0,9% 20ML/KG EV
CEFTRIAXONA 2G EV 12/12 HORAS POR 7-14 DIAS
OU MEROPENEM 2G EV DE 8/8 HORAS POR 10-14 DIAS (suspeita pseudomonas/enterobacteria)
Se >50 anos: + AMPICILINA 2G EV DE 4/4 HORAS
DEXAMETASONA 0,15ML/KG EV DE 6/6 HORAS POR 2 DIAS (começar 30 min antes do atb)
DIPIRONA (500MG/ML) 1G EV 6/6 HORAS
METOCLOPRAMIDA (10MG/2ML): 1 AMP + AD EV 8/8 HORAS
OU BROMOPRIDA (10MG/2ML) 1 AMP EV 8/8HORAS
OMEPRAZOL (40MG/10ML): 20-40MG EV/VO 1X AO DIA PELA MANHA
OBSERVAÇÃO NEUROLÓGICA
SINAIS VITAS

■ Casa — Prescrição — Casa

CIPROFLOXACINO 500MG
TOMAR 01 CP VO DOSE ÚNICA
OU RIFAMPICINA 600MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 2 DIAS

Neuralgia do Trigêmeo · CID G50.9

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Dor paroxística, em choque, no território do trigêmeo (V2/V3), desencadeada por gatilhos (falar/mastigar/to

■ Casa — Prescrição — Casa

CARBAMAZEPINA 200MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS
E/OU
GABAPENTINA 300MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS
Encaminhar Neurologista
*Possibilidade de hidantalizar

Neuralgia Pós Herpética · CID G53.0

■ CAPSAICINA CREME 0,075% APLICAR NA REGIÃO 2-3X AO DIA OU

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

Dor neuropática (queimação/choque) no dermatomo de zoster prévio, com [alodínia]. Pele: cicatrizes/hiperpig

■ Casa — Prescrição — Casa

GABAPENTINA 300MG

TOMAR 01 A 06 CPS 1X AO DIA

OU AMITRIPTILINA 25MG

TOMAR 01 A 03 CPS 1X AO DIA

Orientação: após aplicar creme pode “queimar” por alguns minutos

Paralisia de Bell · CID G51.0

■ Hemograma, PCR – excluir infecções

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

Paralisia facial periférica: acomete fronte (não enrugam testa), sinal de Bell, apagamento do sulco nasolabi

■ Casa — Prescrição — Casa

PREDNISONA 20MG

TOMAR 03 A 04 CPS 1X AO DIA POR 5-7 DIAS

OU PREDNISOLONA 20MG

TOMAR 03 CPS 1X AO DIA POR 5 DIAS

USO OFTÁLMICO

CARMELOSE SÓDICA

PINGAR 1 GOTA EM OLHO AFETADO, SEMPRE QUE NECESSÁRIO

Encaminhar neurologista

Síndrome de Ramsay Hunt

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

Paralisia facial periférica + vesículas em conduto auditivo/pavilhão/orofaringe (zoster ótico). [Otalgia, h

■ Casa — Prescrição — Casa

VALACICLOVIR 1G

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 7 - 10 DIAS

OU ACICLOVIR 400MG

TOMAR 01 CP DE 4/4 HORAS POR 10 DIAS

DIPIRONA 1G

TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE

USO OFTÁLMICO

CARMELOSE SÓDICA

PINGAR 1 GOTA EM OLHO AFETADO, SEMPRE QUE NECESSÁRIO

Casos graves: vertigem, zumbido, perda auditiva -> internar

Encaminhar neurologista

DERMATOLOGIA / PELE E ANEXOS

Vertigem / Labirintite / Tontura · CID R42

■ - Neurite vestibular aguda:

Excluir AVC: Score HINTS

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Neuro: Glasgow 15, sem déficits focais. HINTS: [head-impulse / nistagmo / skew]. Nistagmo [horizontal, unid

■ PS / Sala — Prescrição — PS

DRAMIN B6 -----

TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6H, SE NÁUSEAS OU VÔMITOS

LABIRIN 8MG ----- 1 CAIXA

TOMAR 1 COMPRIMIDO DE 8/8H

OU MECLIN 50MG -----

TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 5 DIAS

OU PREDNISONA 1MG/KG

TOMAR 01 CP 1X AO DIA POR 5 DIAS

AGORA: SF0,9% 100ML + DRAMIN 1 AMP EV

Se não melhorar: METOCLOPRAMIDA 10MG EV

Se não melhorar: DIAZEPAM 1 AMP EV

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Prednisona 20mg ----- 1 caixa

Tomar 3 comprimidos pela manhã, todos os dias, por 5 dias. Corticoterapia oral por 10 dias (5 dias de 60 mg/

OU 1) Prednisona 10mg ----- 1 caixa

Tomar 1 comprimido pela manhã por 4 dias, após o término do item 1). Em seguida, tomar meio comprimido pela

- Neurite vestibular crônica
1) Flunarizina 10mg
Tomar 1 comprimido a noite por 5 dias.
- Sintomático:
2) Cinarizina 25mg -----
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por até 5 dias.
OU 2) Dramin B6 50mg -----
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por até 5 dias.

■ Olhos

Celulite Periorbitária / Pré-Septal

■ - Compressas quentes na área inflamada 3x ao dia Excluir: celulite septal (TC)

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., [febril].
Olho [D/E]: edema e eritema palpebral, SEM proptose, SEM dor à motricidade ocular, SEM oftalmoplegia, acuid

■ Casa — Prescrição — Casa

AMOXICILINA + CLAVULANATO 500MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 10 DIAS
OU MOXIFLOXACINO 400MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 CP 1X AO DIA POR 10 DIAS

Conjuntivite · CID H10

■ Olho direito com hiperemia conjuntival discreta, sem secreção purulenta evidente. Sem edema periorbitário importante

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., afebril.
Olho [D/E]: hiperemia conjuntival difusa, secreção [serosa/purulenta], sem edema palpebral importante. Cór

■ Casa — Prescrição — Casa

USO OFTALMOLÓGICO
1) Tobramicina 0,3% solução oftálmica ----- 1 frasco
Aplicar 1 gota no olho acometido, de 6 em 6 horas, por 7 dias.
2) COLÍRIO LUBRIFICANTE (SYSTANE, LACRIFILM ou LACRIMA) -----
PINGAR 01 GOTA EM OLHO AFETADO DE 4/4 HORAS
3) SORO FISIOLÓGICO 0,9%
APLICAR COMPRESSA GELADA COM SORO FISIOLÓGICO 4X AO DIA NO OLHO AFETADO

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Loratadina 10mg ----- 7 comprimidos
Tomar 1 comprimido à noite por até 7 noites.
2) DIPIRONA 500MG -----
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR

Herpes Zoster Ocular · CID B00.5

■ compressas geladas, deixar a pele seca. OTORRINOLARINGOLOGIA

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Vesículas em dermatomo V1 (fronte/pálpebra), sinal de Hutchinson (ponta do nariz). Olho: hiperemia, [dor, f

■ Casa — Prescrição — Casa

ACICLOVIR 400MG -----
TOMAR 02 CPS DE 4/4 HORAS POR 7 DIAS
PREDNISONA 20MG -----
TOMAR 02 CPS 1X AO DIA

Neurite Óptica · CID H46

■ SOLICITAR HEMOGRAMA, UREIA, CREAT, SÓDIO, POTÁSSIO E TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE AVALIAÇÃO DO OFTALMO E NEUROLOGISTA

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Olho [D/E]: baixa de acuidade visual subaguda, dor à motricidade ocular, discromatopsia. Defeito pupilar af

■ Internação — Na internação

DIETA ORAL BRANDA
METILPREDNISOLONA 1G + SF 400ML EV INFUNDIR EM 30-60 MINUTOS - POR 3-5 DIAS
IVERMECTINA (6MG/CP) 200MCG/KG/DIA POR 1-2 DIAS (Dose usual: 2-3 CP VO DOSE ÚNICA)
DIPIRONA 1-2G EV DE 6/6 HORAS
METOCLOPRAMIDA 10MG EV + AD, DE 8/8 HORAS, SE NAUSEA OU VÔMITO
OMEPRAZOL 20-40MG VO/EV DE 24/24 HORAS, PELA MANHÃ
ORTOPEDIA/ REUMATOLOGIA

Alergia / Rinite Alérgica · CID T78.4

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Pele: [placas urticariformes / sem lesões]. Rinoscopia: mucosa pálida, coriza hialina. AP: MV+ sem sibilos.

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Soro fisiológico 0,9% ----- 1 frasco

Aplicar uma seringa de 20ml de soro fisiológico em cada narina, três vezes ao dia, até melhora dos sintomas

2) Budesonida 64mcg spray nasal ----- 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

OU 2) Fluticasona 50mcg spray nasal ----- 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina, uma vez ao dia, por 10 dias.

OU 2) Mometasona 50mcg spray nasal ----- 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina, uma vez ao dia, por 10 dias.

OU 2) Beclometasona 50mcg spray nasal ---- 1 frasco

Aplicar 2 jatos em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

3) Loratadina 10mg ----- 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido à noite por até 10 noites.

3) Loratadina 1mg/ml ----- 1 frasco > acima de 2a!

< 30kg: Tomar 5 ml por via oral à noite por até 7 noites.

> 30kg: Tomar 10ml por via oral à noite por até 7 noites.

OU 3) Prometazina 25 mg

Tomar 1 comprimido A NOITE por 7 dias.

OU 4) Hidroxizina 25 mg > pode tomar de 8/8h se necessário!

Tomar 1 comprimido à noite por até 10 noites.

x) Hidroxizina 2mg/ml ----- 1 frasco > acima de 6m!

< 40kg: Tomar 2mg/kg/dia divididos em 3 tomadas ao longo dia por até 10d.

> 40kg: 0,7mg/kg de peso corporal de 8 em 8 horas por até 10d. Máximo de 100mg/dia.

4) Prednisona 20mg ----- 10 comprimidos

Tomar 2 comprimidos pela manhã, uma vez ao dia, por até 5 dias.

5) Montelukaste 10 mg

Tomar 1 comprimido à noite por 30 noites.

x) Montelukaste > indicado para > 2 anos

Se 2-5 anos: Tomar 4 mg, uma vez à noite, por até 30 noites.

Se 6-14 anos: Tomar 5 mg, uma vez à noite, por até 30 noites.

Se >15a: seguir prescrição de adulto

Bilastina 20 mg

Tomar 1 comprimido VO pela manhã por 10 dias.

Amigdalite Aguda · CID J03

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Orofaringe: amígdalas hiperemiadas com exsudato; úvula centrada, sem abaulamento. Adenopatia cervical anter

■ Casa — SE BACTERIANA

1) Amoxicilina 500mg ----- 30 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias. (Tomar os 10 dias, mesmo que os sintomas melhorem antes. B

OU 1) Amoxicilina + clavulanato 875+125mg ----- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.

OU 1) Clindamicina 300mg -----

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias.

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Dipirona 500mg ----- 20 comprimidos

Tomar via oral 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.

2) Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml

Tomar via oral 5 mL, 2x por dia, por 5 dias.

3) PREDNISONA 20MG -----

Tomar 1 comprimido pela manhã, por 5 dias.

4) Strepsils pastilhas ----- 1 caixa

Dissolver uma pastilha na boca, duas ou mais vezes ao dia, até o alívio dos sintomas. Limite máximo diário

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Lavagem Nasal com Soro fisiológico 0,9% ----- 1 frasco

Aplicar uma seringa de 20ml de soro fisiológico em cada narina, três vezes ao dia, até melhora dos sintomas

2) Budesonida 64mcg spray nasal ----- 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

Cerume · CID H61.2

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Otosopia [D/E]: rolha de cerume ocluindo o conduto, MT não visualizada. Sem sinais de otite externa/média

■ Casa — Prescrição — Casa

1) CERUMIN -----
APLICAR 5 GOTAS NO OUVIDO AFETADO 3X AO DIA POR 5 DIAS
2) DIPIRONA 500MG -----
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6H SE DOR

Faringoamigdalite · CID J03

■ 75% VIRAL Quadro clínico: dor de garganta, disfagia, mialgia, febre baixa, tosse, coriza hialina e espirros
Exame físico: hiperemia e edema da mucosa faríngea e das amígdalas, com presença de exsudato (raramente). Ausência de adenopatia
20-40% bacteriana
O exame físico revela hiperemia, aumento de tonsilas e exsudato purulento, além de adenomegalia em cadeia jugulodigástrica, observada em 60% dos casos. No hemograma observamos leucocitose com desvio à esquerda.
SE NECESSARIO ATB

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA __/__ | FC __ | FR __ | SatO2 __% | Tax __°C.
Orofaringe: amígdalas hiperemiadas e hipertrofiadas [± exsudato puntiforme]. Linfonodo cervical anterior [d
AP: MV+ sem RA.

■ PS / Sala — Prescrição — PS

IM (SE NECESSÁRIO)

■ PS / Sala — AGORA: PROFENID OU DECADRON

PENICILINA BENZATINA 1,2 MILHOES -----
APLICAR IM, DOSE ÚNICA

■ Casa — Prescrição — Casa

Amoxicilina 500mg ----- 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias.
ou
AMOXICILINA + CLAVULANATO (875 + 125 MG) ----- 20 CPS
TOMAR 1 CP DE 12/12H POR 10 DIAS.

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Dipirona 500mg ----- 20 comprimidos
Tomar via oral 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.
2) Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml
Tomar via oral 5 mL, 2x por dia, por 5 dias.
3) PREDNISONA 20MG -----
Tomar 1 comprimido pela manhã, por 5 dias.
4) Strepsils pastilhas ----- 1 caixa
Dissolver uma pastilha na boca, duas ou mais vezes ao dia, até o alívio dos sintomas. Limite máximo diário

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Lavagem Nasal com Soro fisiológico 0,9% ----- 1 frasco
Aplicar uma seringa de 20ml de soro fisiológico em cada narina, três vezes ao dia, até melhora dos sintomas
2) Budesonida 64mcg spray nasal ----- 1 frasco
Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

IVAS / Amigdalite / Resfriado · CID J06.9 · J03.9 · J00

■ PACIENTE REFERE HÁ DIAS. Nega febre, nega dispneia, nega dor torácica, nega disfagia, nega vômitos e nega prostração. Sem outros sintomas associados.
GERAIS: AUMENTAR INGESTA DE ÁGUA PARA MELHORAR EXPECTORAÇÃO
CENTOR

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA __/__ | FC __ | FR __ | SatO2 __% | Tax __°C.
Orofaringe: hiperemia leve, sem exsudato. Otoscopia: MT translúcida bilateral.
AP: MV+ bilateral, sem RA, eupneico em ar ambiente. Sem linfonodomegalia cervical significativa.

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Dipirona 500mg ----- 20 comprimidos
Tomar via oral 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.
ou
1) Paracetamol 500 mg----- 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se dor ou febre
2) Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml
Tomar via oral 5 mL, 3x por dia, por 5 dias.
3) Cetoprofeno 100mg ----- 1 caixa
Tomar via oral 1 comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias.

ou

Diclofenaco 50mg ----- 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 5 dias.

ou

3) PREDNISONA 20MG -----

Tomar 1 comprimido pela manhã, por 5 dias.

4) Strepsils pastilhas ----- 1 caixa

Dissolver uma pastilha na boca, duas ou mais vezes ao dia, até o alívio dos sintomas. Limite máximo diário

5) DROPROPIZINA 3MG/ML XAROPE 120 ml

Tomar 10 ml de 6 em 6 horas, por 3 dias.

OU 5) Acetilcisteína Xarope (40 mg/mL):

Tomar 15 mL, antes de dormir, via oral, por 5 dias.

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Lavagem Nasal com Soro fisiológico 0,9% ----- 1 frasco

Aplicar uma seringa de 20ml de soro fisiológico em cada narina, três vezes ao dia, até melhora dos sintomas

2) Budesonida 64mcg spray nasal ----- 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

Opções diferentes de anti-histamínico

MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 5 DIAS

Bilastina 20 mg

Tomar 1 comprimido VO pela manhã por 10 dias.

■ Casa — SE PRECISAR DE ATB

Amoxicilina 500mg ----- 30 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias.

Amoxicilina + clavulanato 875+125mg ----- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.

Levofloxacino 750mg ----- 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido, uma vez ao dia, por 10 dias

Claritromicina 500mg ----- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.

Azitromicina 500mg ----- 5 comprimidos

Tomar 1 comprimido, uma vez ao dia, por 5 dias.

Penicilina benzatina 1.200.000 UI IM dose única

Clindamicina 300mg ----- 30 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 10 dias.

■ Casa — Spray para dor de garganta

Hexomedine spray ----- 1 frasco

Aplicar 3 jatos de 4 em 4 horas em garganta se dor.

Otalgia • CID H92.0

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Otoscopia: [normal – considerar causa referida: ATM, dental, faríngea]. Palpação de ATM e cervical. Orofaringe

■ Casa — Prescrição — Casa

DIPIRONA 500MG

TOMAR 01 A 02 CPS DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE

■ Casa — Prescrição — Casa

OTO-XILODASE

APLICAR 5 GOTAS EM OUVIDO AFETADO, 3X AO DIA POR 7 DIAS

Otite Externa • CID H60

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Otoscopia [D/E]: dor à tração do tragus/pavilhão, edema e hiperemia do conduto [± secreção]. MT [visível/não]

■ PS / Sala — Prescrição — PS

IM: DIPIRONA + DECADRON

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Ciprofloxacino + hidrocortisona ----- 1 frasco

Aplicar 3 gotas no ouvido acometido de 12 em 12 horas por 7 dias.

- Otite externa fúngica:

1) Clotrimazol (1%) ----- 1 frasco

Aplicar 3-4 gotas no ouvido acometido de 8 em 8 horas até a resolução.

- Otite necrotizante em tratamento ambulatorial

1) Ciprofloxacino 500 mg ----- 56 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 4 semanas.

2) Dipirona 500mg ----- 20 comprimidos

Tomar 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.

2) Paracetamol 750mg ----- 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas se dor ou febre.

■ Casa — Prescrição — Casa

CIPROFLOXACINO + HIDROCORTISONA (OTOCIRIAX) -----
APLICAR 3 GOTAS NA ORELHA ACOMETIDA DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS

■ Casa — Prescrição — Casa

IBUPROFENO 600MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8HORAS, POR 5 DIAS

Otite Média Aguda · CID H66 · H65

■ ATB indicado se < 6m, otorreia, OMA bilateral < 24m, toxemia, otalgia > 48h, T > 39C ou incerteza de reavaliação
> ATENÇÃO: amoxicilina se < 2a: 10d de tratamento; se > 2a: 7 dias

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Otoscopia [D/E]: MT abaulada, hiperemiada, opaca [± otorreia]. Região retroauricular sem edema/eritema. Mím

■ PS / Sala — Prescrição — PS

IM: DIPIRONA + DECADRON

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Amoxicilina 500 mg ----- 21 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias.

OU 1) Amoxicilina + clavulanato 875+125mg ----- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.

OU 1) Axetilcefuroxima 500mg ----- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias

OU 1) Azitromicina 500 mg VO dose única seguido de 250 mg de 24/24 horas, do 2º ao 5º dia (dose máxima de

■ Casa — Se OTITE MÉDIA CRÔNICA simples agudizada

1) Ciprofloxacino + hidrocortisona ----- 1 frasco

Aplicar 3 gotas no ouvido acometido de 12 em 12 horas por 7 dias.

2) Ciprofloxacino 500mg ----- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias.

3) Prednisona 20mg ----- 10 comprimidos

Tomar 2 comprimidos de manhã por até 5 dias.

4) Proteção auricular + ORL!!

■ Casa — Prescrição — Casa

AMOXICILINA + CLAVULANATO 875/125MG -----

TOMAR 01 CP DE 12/12HORAS POR 10 DIAS

Perfuração Membrana Timpânica · CID H72

■ NÃO molhar ouvido, retorno com otorrino em 10 dias

OUTROS

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

Otoscopia [D/E]: perfuração da MT [central/marginal], [± otorreia]. Avaliar história de trauma/otite/barotr

■ Casa — Prescrição — Casa

LEVOFLOXACINO 500MG

TOMAR 01 CP 1X AO DIA POR 10 DIAS

PREDNISONA 20MG

TOMAR 01 CP 1X AO DIA POR 5 DIAS

Rinite Alérgica · CID J30

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Rinoscopia: mucosa nasal pálida/edemaciada, coriza hialina. Sem secreção purulenta. Orofaringe sem exsudato

■ Casa — Prescrição — Casa

1) DEXCLORFENIRAMINA 2MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 7 DIAS

OU 1) LORATADINA 10MG

TOMAR 01 CP 1X A NOITE POR 7 DIAS

OU 1) HIDROXIZINA 25MG

TOMAR 01 CP 1X A NOITE POR 7 DIAS

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Lavagem Nasal com Soro fisiológico 0,9% ----- 1 frasco

Aplicar uma seringa de 20ml de soro fisiológico em cada narina, três vezes ao dia, até melhora dos sintomas

2) Budesonida 64mcg spray nasal ----- 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

Sinusite Aguda · CID J01

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Face: dor à palpação/percussão de seios [maxilar/frontal]. Rinoscopia: secreção [purulenta] em meato médio.

■ Casa — Prescrição — Casa

1) PREDNISONA 20MG

TOMAR 01 CP PELA MANHA POR 5 DIAS

2) DIPIRONA 500MG

TOMAR 01 A 02 CPS DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Lavagem Nasal com Soro fisiológico 0,9% ----- 1 frasco

Aplicar uma seringa de 20ml de soro fisiológico em cada narina, três vezes ao dia, até melhora dos sintomas

2) Budesonida 64mcg spray nasal ----- 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

USO DE ATB SE MAIS DE 10 DIAS OU SINAL DA DUPLA PIORA, OU FEBRE MUITO ALTA PERSISTENTE + Dor facial intensa

■ Casa — Prescrição — Casa

AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125MG ----- 30 CPS

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 10 DIAS

OU LEVOFLOXACINO 750MG -----

TOMAR 01 CP 1X AO DIA POR 5-7 DIAS

Tosse Subaguda Pós-Viral · CID R05.2

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Orofaringe: [gotejamento pós-nasal]. AP: MV+ sem RA, SatO2 preservada. Tosse há 3-8 semanas após IVAS, sem

■ Casa — Prescrição — Casa

1) DROPROPIZINA 3MG/ML XAROPE 120 ml

Tomar 10 ml de 6 em 6 horas, por 3 dias.

■ Casa — Prescrição — Casa

1) BUDESONIDA 50MCG

APLICAR 1 JATO EM CADA NARINA DE 12/12 HORAS POR 5 DIAS

Tórax / Cardio-Pneumo

Asma — Manutenção Gina 2026 · CID J45

■ >>> CONCEITO-CHAVE: NÃO usar SABA (salbutamol) ISOLADO como alívio. Todo paciente deve ter corticoide inalatório (CI). SABA sozinho = mais crises.

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., eupneico (fora de crise).

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

AP: MV+ bilateral, [sibilos esparsos ou ausentes]. Avaliar controle (sintomas diurnos, despertares, uso de

■ Casa — Prescrição — Casa

TRACK 1 (PREFERIDO) – alívio com CI-FORMOTEROL (budesonida/formoterol)

STEP 1-2: BUDESONIDA + FORMOTEROL 200/6 MCG

INALAR 1 CÁPSULA/DOSE SE NECESSÁRIO (alívio anti-inflamatório - AIR)

STEP 3 (MART): BUDESONIDA + FORMOTEROL 200/6 MCG

INALAR 1 DOSE DE 12/12H (manutenção)

+ 1 DOSE SE NECESSÁRIO p/ sintomas (mesma bombinha)

STEP 4 (MART): BUDESONIDA + FORMOTEROL 200/6 MCG

INALAR 2 DOSES DE 12/12H (manutenção)

+ 1 DOSE SE NECESSÁRIO (máx ~12 doses/dia)

STEP 5: ENCAMINHAR especialista (fenotipagem, LAMA, biológicos).

TRACK 2 (ALTERNATIVO) – só se Track 1 indisponível, boa adesão e asma estável

alívio com SABA ou CI-SABA

STEP 1: CI dose baixa SEMPRE que usar o SABA

STEP 2: CI dose baixa DIÁRIO (ex.: BUDESONIDA 200MCG 1 dose 12/12h)

+ SALBUTAMOL 100MCG 1-2 jatos SE NECESSÁRIO

STEP 3: CI-LABA (formoterol/budesonida ou salmeterol/fluticasona) 12/12h + SABA SOS

STEP 4: CI-LABA dose MÉDIA 12/12h + SABA SOS

ADD-ON (qualquer step, se controle insuficiente): MONTELUCASTE 10MG À NOITE

ENXAGUAR A BOCA após CI (evita candidíase oral).

Bradicardia Instável · CID R00.1

Exame físico

[Rebaixado/sudoreico].

SSVV: FC < 50 ___ | PA ___/___ (hipotensão?) | SatO2 ___.

Sinais de má perfusão/instabilidade (5D: dor torácica, dispneia, ↓consciência, desmaio, ↓PA). ECG: [tipo de

■ PS / Sala — Prescrição — PS

MOV, DEXTRO

ATROPINA 1MG EV BOLUS – REPETIR A CADA 3-5 MINUTOS (MÁX 3MG)

■ PS / Sala — Sem resposta

DOPAMINA 5 AMP + 200ML SG – INICIAR COM 20ML/H

OU EPINEFRINA (1MG) 10 AMP + 90ML SG – INICIAR COM 6ML/H (SE RESPONDER, PODE DIMINUIR PARA 3ML/H)

■ Casa — Sem resposta

FENTANIL (50MCG/ML) – 2ML + 8ML SF – FAZER 20 A 30 MCG

OU MORFINA 4 A 5 MG

MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO: ligar a função MP, escolher modo fixo, escolher a FC (60), iniciar a estimulação (energia 40, ir aumentando aos poucos 10 em 10).

TRANSFERIR PACIENTE

Bronquite · CID J20

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

AP: MV+ bilateral, [roncos/sibilos esparsos], sem estertores crepitantes localizados. SatO2 preservada.

■ Casa — Prescrição — Casa

BECLOMETASONA 200MCG

02 JATOS DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS OU ATÉ ALÍVIO DE SINTOMAS

SALBUTAMOL 100MCG

02 JATOS ATÉ DE 4/4 HORAS, SE CRISE

DIPIRONA 500MG

TOMAR 01 CP DE 6/6HORAS, SE DOR OU FEBRE

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Lavagem Nasal com Soro fisiológico 0,9% ----- 1 frasco

Aplicar uma seringa de 20ml de soro fisiológico em cada narina, três vezes ao dia, até melhora dos sintomas

2) Budesonida 64mcg spray nasal ----- 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.0

Coqueluche · CID A37

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., afebril ou febre baixa.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Paroxismos de tosse com guincho inspiratório/vômito pós-tosse. AP: geralmente limpo entre acessos. [Contacto

■ Casa — Prescrição — Casa

AZITROMICINA 500MG ----- 05 CPS

TOMAR 01 CP 1X AO DIA POR 5 DIAS

DIPIRONA 500MG

TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE

BROMOPRIDA 10MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, SE NÁUSEA OU VÔMITO

Crise de Asma — Exacerbação · CID J45

■ ATENÇÃO GINA 2026: PREFERIR SALBUTAMOL. FENOTEROL passou a NÃO recomendado (risco cardiovascular e mortalidade). MgSO4 NEBULIZADO sem benefício (usar EV).

- O2 SE SAT < 94% (meta 93–95%)

Exame físico

[REG/MEG], [taquipneico], fala [frases/palavras].

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

AP: sibilos difusos, tiragem, uso de acessória, [tórax silencioso = gravíssimo]. SatO2 ___%. FR ___. Nível de

■ PS / Sala — NA UNIDADE

- SALBUTAMOL 100MCG: 4-10 JATOS COM ESPAÇADOR DE 20/20 MIN POR 1 HORA

+ BROMETO DE IPRATRÓPIO 20MCG: 4-8 JATOS DE 20/20 MIN POR 1 HORA

OU NEBULIZAÇÃO: SALBUTAMOL 10-20 GOTAS + IPRATRÓPIO 30-40 GOTAS + SF 0,9% 3ML

- CORTICOIDE SISTÊMICO PRECOCE (até 1h):

PREDNISONA 40-50MG VO OU HIDROCORTISONA 200MG EV

- REAVALIAR após 1ª hora; se não melhorar, repetir broncodilatador.

■ PS / Sala — CRISE GRAVE / SEM RESPOSTA

- SULFATO DE MAGNÉSIO 2G EV + SF 0,9% 100-250ML – CORRER EM 20 MIN (dose única)

- Gasometria, considerar VNI, contato com retaguarda/UTI

■ Casa — PARA CASA

- PREDNISONA 40MG/DIA POR 5-7 DIAS (criança 3-5 dias)
- 1) FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200 MCG
- MANUTENÇÃO: INALAR 1 CÁPSULA DE 12/12H (enxaguar a boca após)
- ALÍVIO: SE FALTA DE AR/SINTOMAS, INALAR 1 CÁPSULA EXTRA
- NÃO ULTRAPASSAR ~12 DOSES/DIA NO TOTAL (manutenção + alívio)
- Encaminhar p/ acompanhamento.

Dissecção Aguda de Aorta · CID I71

Exame físico

MEG, dor torácica/dorsal intensa 'rasgando'.
SSVV: PA ___/___ (assimetria entre MMSS?), FC ____.
Pulsos assimétricos/déficit de pulso. [Sopro de insuficiência aórtica]. Avaliar déficit neurológico/isquemia

■ PS / Sala — Prescrição — PS

ECG, RX TÓRAX, HEMOGRAMA, LACTATO, UREIA, CREAT, TGO, TGP
DIETA ZERO
RINGER LACTATO 500ML EV, S/N
MORFINA (10mg/ml): 1 AMP + 9ML AD - FAZER 4ML
Deixar FC <60 e PAS entre 100 e 120: METOPROLOL 5MG BOLUS EV - repetir de 10/10 minutos S/N (Max 20mg)

■ PS / Sala — Se não melhorar com droga acima

NIPRID (50mg/2ml): 1 AMP + 250ML SG5% - FAZER EV EM BIC, COMEÇAR COM 2ML/H (aumentar/reduzir conforme necessidade)
MONITORIZAÇÃO EM LEITO DE EMERGENCIA
CAT O2 2L/MIN, SE SAT <92% OU DISPNEIA
CABECEIRA ELEVADA
SINAIS VITAIS 1/1 HORA

Dor Torácica — Abordagem Rápida · CID R07

■ PASSO 1 — ECG EM ATÉ 10 MINUTOS + MONITORIZAR (MOV).

0-3 → BAIXO risco (MACE ~1-2%). Considerar alta com troponina negativa seriada + seguimento. 4-6 → MODERADO. Internar/observar, troponina seriada, avaliar isquemia. ≥ 7 → ALTO. Estratégia invasiva precoce / transferência p/ serviço com hemodinâmica.
- ECG (REPETIR seriado — 1 ECG normal NÃO exclui SCA) - Troponina seriada (0h e 1h, ou 0h e 3h) - Rx tórax, hemograma, eletrólitos, função renal, glicemia - D-dímero SE suspeita de TEP (e Wells baixo); Angio-TC se D-dímero+ ou alta suspeita SE SCA CONFIRMADA/SUSPEITA → seguir protocolo IAM (AAS, clopidogrel, etc.) e TRANSFERIR/INTERNAR.

Exame físico

[BEG/MEG].
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
ACV: RCR 2T, [sopros, B3/B4], turgência jugular. AP: MV+ [estertores/abolido]. Reprodutível à palpação? Pul

■ Casa — PASSO 2 — Pensar nas 6 CAUSAS QUE MATAM antes de "musculoesquelético"

1. SCA / IAM → ver protocolo IAM
2. DISSECÇÃO DE AORTA → dor "rasgando", migratória, assimetria de pulso/PA entre braços
3. TEP → dispneia súbita, taquicardia, dor pleurítica (Wells / PERC + D-dímero)
4. PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO → dispneia, MV abolido, desvio traqueia, turgência jugular
5. TAMPONAMENTO CARDÍACO → hipotensão + turgência jugular + bulhas abafadas (Beck)
6. RUPTURA ESÔFAGO (Boerhaave) → vômito + dor torácica + enfisema subcutâneo

■ Casa — >>> SCORE HEART (estratifica risco de SCA na emergência)

H History (anamnese): pouco suspeita 0 / moderada 1 / muito suspeita 2
E ECG: normal 0 / alt. inespecífica repolarização 1 / infra ST 2
A Age (idade): < 45a = 0 / 45-64a = 1 / ≥ 65a = 2
R Risk factors: nenhum 0 / 1-2 fatores 1 / ≥3 ou aterosclerose conhecida 2
T Troponina: normal 0 / 1-3x 1 / > 3x = 2
(Fatores: HAS, DM, dislipidemia, tabagismo, obesidade, história familiar)

DPOC Exacerbado · CID J44

Exame físico

[REG], [taquipneico], tórax em tonel.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
AP: MV↓ difuso, sibilos/roncos, expiração prolongada. SatO2 ___% (meta 88-92%). Uso de musculatura acessória

■ PS / Sala — AQUI

NEBULIZAÇÃO: FENOTEROL 10 GOTAS + IPRATRÓPIO 30 GOTAS + SF 0,9% 3 ML DE 20/20 MINTOS POR 1 HORA
PREDNISONA 40MG VO OU HIDROCORTISONA 300MG EV
CAT NASAL 2-3L (meta: 88-92%)

■ Casa — Prescrição — Casa

AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 10 DIAS
PREDNISONA 20MG -----
TOMAR 02 CP 1X AO DIA POR 7 DIAS
USO INALATÓRIO
FAZER INALAÇÃO DE 6/6 HORAS POR 5 DIAS:
SALBUTAMOL 10 GOTAS -----

IPRATRÓPIO 20 GOTAS -----
SF 0,9% 2ML -----
OU SALBUTAMOL SPRAY 100MCG -----
FAZER 2 JATOS DE 6/6 HORAS POR 5 DIAS
IPRATRÓPIO SPRAY 20MCG -----
FAZER 2 JATOS DE 6/6 HORAS POR 5 DIAS

Edema Agudo de Pulmão · CID J81

■ - Dieta zero (até melhora de dispneia)

Exame físico

MEG, dispneia intensa, ortopneia, sudoreico.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
AP: estertores crepitantes bilaterais até ápices, [sibilos]. ACV: taquicardia, B3, turgência jugular. SatO2

■ PS / Sala — Prescrição — PS

- VNI
- Furosemida 20mg/2ml: 1mg/kg
- Morfina 10mg/ml (não é para todos): 3 a 5 ml EV -> 1 amp + 9 mlSF
- Tridil (em cardiopatia isquêmica) ou Niprid (mais usado): 1 amp + 240ml SG 5% EV BIC (Paciente com 70kg c
com 10ml/h)
- SVD (quantificar diurese)
- Glicemia capilar 2/2h
- Se HGT < 60: glicose hipertônica 50%
- Insulina regular SOS
- Monitorização
- Cabeceira elevada

IAM — Infarto Agudo do Miocárdio · CID I21.9

Exame físico

[BEG/MEG], sudoreico, ansioso.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Dor precordial em aperto, irradiação [MSE/mandíbula], >20 min. ACV: RCR 2T, [B3/B4, sopro, atrito]. AP: [es

■ Casa — Prescrição — Casa

ECG, TROPONINA, CKMB
JEJUM
MOV + CAT NASAL SE SAT <90%
SF 0,5ml/kg/h
AAS 300MG VO MASTIGADO
CLOPIDOGREL 75 MG 04 CPS VO OU se ≥ 75 anos 01 CP VO
DIPIRONA (500mg/ml): 1G EV 6/6H
DINITRATO ISOSSORBIDA (5MG): 1 CP SUBLINGUAL - repetir a cada 5 min, se necessário (CONTRAINDICAÇÕES!)
MORFINA (10mg/ml): 1 amp + 9ml ad - fazer 2 a 5 ml, repetir a cada 5 min, se necessário
ENCAMINHAR/ INTERNAR UTI

Influenza · CID J11

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., [febril].
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Orofaringe: hiperemia leve. AP: MV+ bilateral, sem RA, SatO2 preservada. Sem sinais de gravidade (sem dispn

■ Casa — Prescrição — Casa

OSELTAMIVIR 75MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 5 DIAS
*correção para função renal

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Dipirona 500mg ----- 20 comprimidos
Tomar via oral 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.
2) Maleato de dexclorfeniramina 2mg/5ml
Tomar via oral 5 mL, 3x por dia, por 5 dias.
3) Cetoprofeno 100mg ----- 1 caixa
Tomar via oral 1 comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias.
ou
3) PREDNISONA 20MG -----
Tomar 1 comprimido pela manhã, por 5 dias.
4) Strepsils pastilhas ----- 1 caixa
Dissolver uma pastilha na boca, duas ou mais vezes ao dia, até o alívio dos sintomas. Limite máximo diário
5) Acetilcisteína Xarope (40 mg/mL):
Tomar 15 mL, antes de dormir, via oral, por 5 dias.

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Lavagem Nasal com Soro fisiológico 0,9% ----- 1 frasco
Aplicar uma seringa de 20ml de soro fisiológico em cada narina, três vezes ao dia, até melhora dos sintomas
2) Budesonida 64mcg spray nasal ----- 1 frasco

Aplicar 1 jato em cada narina de 12 em 12 horas por 10 dias.

Insuficiência Cardíaca · CID I50

Exame físico

[REG], [dispneico].

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

ACV: turgência jugular, B3, [sopros]. AP: estertores crepitantes bibasais. Edema de MMII, [hepatomegalia, a

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Perfil B

- Dieta zero até compensação clínica

- Restrição hídrica

- VNI

- Se sat <90%: máscara O2

- Furosemida (20mg/2ml): 1mg/kg EV

- Hidralazina 25 a 100mg VO 8/8h OU Nitroprussiato (50mg/2ml): 1 amp + 248ml SG 5% EV em BIC - iniciar com 10ml/h

■ PS / Sala — Perfil C

- Dieta zero

- Restrição hídrica

- Furosemida (20mg/2ml): 1mg/kg EV

- Nitroprussiato (50mg/2ml): 1 amp + 248ml SG 5% EV - iniciar com 10ml/h

- Se hipotensão: Noradrenalina (1mg/ml) 20 ml + 80ml SG5% EV em BIC - iniciar 1ml/h

- Encaminhar.

■ Casa — Perfil D

- Dieta oral conforme aceitação

- SF 0,9% 20ml/kg em 24h

- Encaminhar

Oclusão Arterial Aguda · CID I74.3

■ HEMOGRAMA, UREIA, CREATININA, SÓDIO, POTÁSSIO, COAGULOGRAMA / USG DOPPLER ARTERIAL urgente

Não aguardar resultado de exames para início de tratamento.

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., dor intensa no membro.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Membro [___]: 6 P – dor, palidez, ausência de pulso, parestesia, paralisia, poiquilotermya (frio). TEC alarg

■ Casa — Prescrição — Casa

ENOXAPARINA 1MG/KG 12/12H

AQUECIMENTO PASSIVO DO MEMBRO

CONTATO COM CIRURGIÃO VASCULAR

Pneumonia · CID J18

■ - Solicitar raio-x, solicitar laboratório. Internação se SatO2 < 92%,

CURB-65 não muda com idade (a idade ≥65 já é 1 ponto). Reescreveria: 0–1 ambulatorial; ≥2 considerar internação; ≥3 grave.

- Rx tórax - Hemograma, ureia, creatinina, eletrólitos - Avaliar necessidade de internação

Exame físico

REG/BEG, [febril, taquipneico?].

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

AP: estertores crepitantes em base [D/E], [± sopro tubário, ↑FTV]. SatO2 __%. CURB-65: C__ U__ R__ B__ (ida

■ Casa — Prescrição — Casa

AMOXICILINA + CLAVULANATO 875/125MG ----- 20 CPS

TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 10 DIAS

OU LEVOFLOXACINO 500MG----- 7 CPS

TOMAR 01CP 1X AO DIA POR 7 DIAS

DIPIRONA 500MG -----

TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE

BROMOPRIDA 10MG-----

TOMAR 01 CP DE 8/8HORAS, SE NAUSEA OU VÔMITO

NEBULIZAÇÃO COM SF 0,9%

■ Internação — Internação

- Levofloxacin 750mg: 1 amp 1x/dia

OU Ceftriaxone 2g 1x/dia + Azitromicina 500mg 1x/dia EV

OU Clavulin + Azitromicina 500mg 1x/dia EV

- Glicemia capilar 4/4h

- Se HGT < 60: glicose hipertônica 50%

- Insulina regular SOS

Taquiarritmias • CID I49

■ Flutter atrial: CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA 50J
Fibrilação atrial: CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA 120J
Taquicardia supraventricular: CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA 50J
TV monomórfica: CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA100J
TV polimórfica: CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA 200J
Torsades de pointes: DESFIBRILAÇÃO 200J BIFÁSICO + SULFATO DE MG 22 EV EM 15 MIN
Paciente instável

Exame físico

[BEG/instável], palpitações.
SSVV: FC __ (>100) | PA __/__ | SatO2 __%.
Avaliar instabilidade (dor torácica, dispneia, ↓consciência, hipotensão). ECG: QRS [estreito/largo], R-R [r

■ PS / Sala — Cardioversão sincronizada

- MONITORIZAR, ACESSO VENOSO
- FENTANIL (100MCG/2ML): 1 AMP + 8ML AD - FAZER 2ML EV BOLUS
- ETOMIDATO (20MG/10ML): ½ AMPOLA EV BOLUS
- VENTILAÇÃO COM AMBU
- SINCRONIZAR O APARELHO, COLOCAR A CARGA ADEQUADA
- COLOCAR GEL NAS PÁS

■ PS / Sala — Paciente estável

MOV
DEXTRO
Taquicardia supraventricular: MANOBRA VAGAL E/OU ADENOSINA 6MG/12MG EV BOLUS + FLUSH 10ML SF
Fibrilação atrial: AMIODARONA 300MG + 250ML SG5% EM 30 MIN
MANUTENÇÃO: AMIODARONA 900MG EM 250ML SG5% CORRER EM 24 HORAS
OU METOPROLOL 5MG EV EM 5 MIN (1mg por minuto) - REPETIR A CADA 15 MIN, SE NECESSARIO (Max 15 mg)
OU DILTIAZEM 0,25MG/KG EV EM INFUSÃO LENTA
Flutter atrial: AMIODARONA 300MG + 150ML SG5% EM 30 MIN
MANUTENÇÃO: AMIODARONA 900MG EM 250ML SG5% CORRER EM 24 HORAS
OU METOPROLOL 5MG EV
TV monomórfica: AMIODARONA 150MG EV EM 10 MIN.
MANUTENÇÃO: 1MG/MIN (6h), 0,5 MG/MIN (18h)
TV polimórfica: AMIODARONA 150MG EV EM 10 MIN
MANUTENÇÃO: 1MG/MIN (6h), 0,5MG/MIN (18h)
Torsades de pointes: SULFATO DE MG 2G EV EM 15 MIN

Tosse e SRAG

Exame físico

[REG], [dispneico].
SSVV: PA __/__ | FC __ | FR __ | SatO2 __% | Tax __°C.
AP: MV+ [estertores], SatO2 __%. Avaliar sinais de gravidade (FR≥24, SatO2<95%, esforço, piora do estado ge

■ Casa — Prescrição — Casa

- 1) Vick 44E ----- 1 frasco
Tomar 15 ml de 8 em 8 horas se tosse persistente.
ou
1)DROPROPIZINA 3MG/ML XAROPE 120 ml
Tomar 10 ml de 6 em 6 horas, por 3 dias.
2) Strepsils pastilhas ----- 1 caixa
Dissolver uma pastilha na boca, duas ou mais vezes ao dia, até o alívio dos sintomas. Limite máximo diário
3) Oseltamivir 75mg ----- 10 comprimidos
Tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 5 dias.
4) Loratadina 10 mg ----- 7 comprimidos
Tomar 1 cp a noite por 7 dias

Tromboflebite Superficial · CID 180

■ Abrir Whitebook para avaliar risco.

- Lavar lesão com Soro fisiológico ou Clorexidine Dergemante - Aplicar pomada/curativo - Colocar gaze úmida - Colocar gaze seca e fechar com micropore.

Baixo risco

Risco intermediário

POMADA ENZIMÁTICA COLAGENSE – Iruxol, Kollagenase, Sanyl APLICAR A POMADA SOBRE A LESÃO, COLOCAR GAZE ÚMIDA E COBRIR COM GAZE SECA E FIXAR. TROCA A CADA 24 HORAS. Indicação: feridas com tecido desvitalizado.

CURATIVO COM ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS – Agederm, ativoderme, dersani APLICAR SOBRE A LESÃO, COBRIR COM GAZE ESTÉRIL E FIXAR. TROCA A CADA 24 HORAS OU ANTES, SE NECESSÁRIO. Indicação: prevenção de úlceras de pressão, feridas abertas superficiais com ou sem infecção. Antes de usar: remover o exsudato e tecido desvitalizado.

CURATIVO COM HIDROCOLÓIDES – Hydrocoll, Duoderm, Comfeel, Tegaserb APLICAR CURATIVO SOBRE A LESÃO. TROCA A CADA 1 A 7 DIAS, CONFORME NECESSIDADE. Indicação: feridas abertas não infectadas, com leve a moderada exsudação; prevenção de úlceras de pressão não infectadas. Contraindicação: ferida infectada, com tecido desvitalizado ou necrose; queimaduras de 3º grau

CURATIVO COM HIDROGEL – Duoderm Gel, Hydrosorb, Hypergel APLICAR SOBRE A LESÃO E OCLUIR A FERIDA COM GAZE ESTÉRIL. TROCA A CADA 1 A 3 DIAS, CONFORME NECESSIDADE. Indicação: feridas superficiais moderada ou baixa exsudação; remover crostas, fibrinas, tecidos desvitalizados ou necrosados.

CURATIVO COM ALGINATO DE CÁLCIO – Algoderm, Curasorb, Sorbalgon MODELAR O CURATIVO NO INTERIOR DA FERIDA, UMEDECENDO A FIBRA COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA. NÃO DEIXAR QUE O CURATIVO ULTRAPASSE A BORDA DA FERIDA. OCLUIR COM GAZE ESTÉRIL. Indicação: feridas abertas, sangrantes, altamente exsudativas com ou sem infecção, até a redução do exsudato.

CARVÃO ATIVADO – Carboflex, Vliwaktiv COLOCAR O CURATIVO SOBRE A FERIDA. OCLUIR COM GAZE ESTÉRIL. TROCA A CADA 1 A 4 DIAS, CONFORME NECESSIDADE. Indicação: feridas fétidas, infectadas e exsudativas.

SULFADIAZINA DE PRATA – Dermazine, Pratazine APLICAR O CREME NA LESÃO. COLOCAR GAZE ÚMIDA E COBRIR COM GAZE ESTÉRIL. TROCA A CADA 12 HORAS OU ANTES, SE NECESSÁRIO. Indicação: feridas causadas por queimaduras ou que necessitem de ação antibacteriana. <https://www.scielo.br/j/rcbc/a/LFCNqqNQH9zZqjJgNLCYkws/> INFECTOLOGIA

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Membro: cordão venoso endurecido, eritematoso, doloroso ao longo de trajeto de veia superficial, SEM edema

■ Casa — Prescrição — Casa

IBUPROFENO 400MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS

OU DICLOFENACO 50MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS

■ Casa — Prescrição — Casa

IBUPROFENO 400MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS

OU DICLOFENACO 50MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS

■ Casa — Por 45 dias

ENOXAPARINA 40MG/0,4ML

APLICAR 40MG SC DE 24/24 HORAS POR 45 DIAS

OU RIVAROXABANA 10MG

TOMAR 01 CP 1X AO DIA POR 45 DIAS

Alto risco (paciente com fatores de risco para TEV/TVP, recorrência da trombose após cessar anticoagulação)

TVP WELLS

■ Casa — Prescrição — Casa

IBUPROFENO 400MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS

OU DICLOFENACO 50MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS

■ Casa — Por 3 meses

ENOXAPARINA

1mg/kg SC DE 12/12 HORAS

OU RIVAROXABANA 15MG

TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 21 DIAS, APÓS:

RIVAROXABANA 20MG

TOMAR 01 CP 1X AO DIA

Para todos – ORIENTAÇÕES: COMPRESSA MOURA OU FRIA 3X AO DIA ATÉ MELHORA, ELEVÇÃO DOS MEMBROS, MEIAS COMPRESSIVAS.

FERIDAS

Trombose Venosa · CID 182

■ HEMOGRAMA, UREIA, CREATININA, NA, K, TGO, TGP, USG DOPPLER VENOSO

Tratamento ambulatorial

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Membro [___]: edema assimétrico, dor à palpação da panturrilha, [empastamento, ↑temperatura, dilatação venosa]

■ PS / Sala — Se Clearance <30

HEPARINA NÃO FRACIONADA 25000 UNIDADES/5ML

FAZER 5ML + SF 0,9% 245ML (concentração: 100U/ml) – dose de ataque 80U/kg

Dose de manutenção: 18U/kg/hora EV em BI por pelo menos 5 dias

E
VARFARINA 5MG VO 1X AO DIA
CONTROLE TAP /INR
DIPIRONA 1G 6/6HORAS
BROMOPRIDA 10MG EV 8/8 HORAS
CETOPROFENO 1 AMP EV 12/12 HORAS
MANTER MEMBROS ELEVADOS
REPOUSO RELATIVO NO LEITO
ALTA HOSPITALAR QUANDO INR ENTRE 2 E 3

■ Casa — Prescrição — Casa

RIVAROXABANA 15MG -----
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS, POR 3 SEMANAS
RIVAROXABANA 20MG -----
TOMAR 01 CP 1X AO DIA POR 3 MESES
DIPIRONA 1G -----
TOMAR 01 CP 6/6 HORAS, SE DOR
DEOCIL SL 10MG
TOMAR 01 CPDE 12/12 HORAS, SE DOR INTENSA
OU

■ Casa — Prescrição — Casa

VARFARINA 5MG -----
TOMAR 01 CP AS 18H00
Controle INR a cada 15 dias

■ Internação — Se internação

DIETA SEM RESTRIÇÕES
ENOXAPARINA 1mg/kg (máx 100mg) SC 12/12 HORAS
OU

■ Abdome / Gastro

Abdome Agudo Obstrutivo • CID K56.6

■ RX ABDOME AGUDO (TÓRAX AP, ABDOME DEITADO, ABDOME EM PÉ), HEMOGRAMA, PCR, UREIA, CREATININA, SÓDIO, POTASSIO.
TC ABDOME COM CONTRASTE

Exame físico

[REG/MEG], [desidratado].
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Abdome distendido, timpânico, RHA [aumentados/metálicos ou abolidos], dor difusa, [parada de eliminação de

■ PS / Sala — Se brida/aderência

DIETA ZERO
SONDA NASOGASTRICA ABERTA
DIPIRONA 2G EV 4/4H
TRAMAL 100MG + BROMOPRIDA 10MG EV, SE NECESSÁRIO
LUFTAL 125MG 4/4H VO OU SNG
500ML SF 0,9% + 5 AMP SG 50% + 1 AMP NACL 20% + 1 AMP KCL 19,1% 6/6H

■ Casa — Formula hidratação basal

20 - 30ML/KG DE AGUA
400KCAL DE GLICOSE
2 MEQ/KG NA
1 MEQ/KG K
SINAIS VITAIS
AGUARDAR 24-36H OU CHAMAR EQUIPE CIRURGIA.
Se repercussões sistêmicas (febre, taquicardia, leucocitose, prostração):
CHAMAR EQUIPE CIRURGIA

Apendicite Aguda — Score de Alvarado · CID K35

■ ANAMNESE: dor que MIGRA para FID, anorexia, náusea/vômito, febre.
Pico clássico: dor periumbilical → migra p/ FID em 12–24h.
M Migração da dor p/ FID 1
A Anorexia 1
N Náusea/vômito 1
T Dor à palpação em FID (Tenderness) 2
R Descompressão dolorosa (Rebound/Blumberg). 1
E Elevação temperatura ≥ 37,3°C 1
L Leucocitose > 10.000 2
S Desvio à esquerda (neutrófilos > 75%) 1
≤ 4 → BAIXA probabilidade. Apendicite improvável. Reavaliar/alta com retorno e sinais de alarme.
5–6 → INTERMEDIÁRIA. Observação + IMAGEM (USG ou TC).
7–8 → PROVÁVEL. Imagem + AVALIAÇÃO CIRÚRGICA.
≥ 9 → MUITO PROVÁVEL. AVALIAÇÃO CIRÚRGICA direta.
NA UNIDADE: - DIETA ZERO - SF 0,9% ou Ringer Lactato EV - DIPIRONA 1G EV 6/6H, SE DOR (analgesia NÃO mascara o diagnóstico — pode/deve dar) - ONDANSETRONA 4MG EV 8/8H, SE NÁUSEA/VÔMITO - Se cirurgia indicada / suspeita perfuração → ATB pré-op: CEFTRIAXONA 2G EV 1X AO DIA + METRONIDAZOL 500MG EV 8/8H - AVALIAÇÃO/CONTATO CIRURGIA GERAL
>>> SCORE DE ALVARADO (0–10) — "MANTRELS"
INTERPRETAÇÃO

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., [febril].
SSVV: PA __/__ | FC __ | FR __ | SatO2 __% | Tax __°C.
Abdome: dor em FID (McBurney), Blumberg [+], [Rovsing, psosas, obturador]. Defesa localizada. Alvarado: __ p

■ Casa — SOLICITAR

- Hemograma, PCR
- Urina I (excluir ITU/cálculo)
- Beta-hCG (TODA mulher em idade fértil – excluir gravidez/ectópica)
- USG abdome: 1ª linha em jovens magros, crianças, gestantes
- TC abdome COM contraste: adultos (melhor acurácia), dúvida diagnóstica, obesos
ATENÇÃO: Alvarado é APOIO, não substitui clínica. Mulher jovem com dor em FID
→ sempre pensar em causa ginecológica (ectópica, cisto roto, DIP) e pedir beta-hCG.

Candidíase Oral · CID B37

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Cavidade oral: placas brancas removíveis (aspecto de leite coalhado) em mucosa jugal/língua/palato, com bas

■ Casa — Prescrição — Casa

NISTATINA 100.000
TOMAR 1 A 6 ML 4X AO DIA POR 7 – 14 DIAS. DEVE SER BOCHECHADA E MANTIDA POR VÁRIOS MINUTOS NA
CAVIDADE ORAL ANTES DE SER ENGOLIDA.

Colecistite Aguda · CID K81

Exame físico

[REG], febril.
SSVV: PA __/__ | FC __ | FR __ | SatO2 __% | Tax __°C.
Abdome: dor em HD, sinal de MURPHY POSITIVO, [defesa localizada]. RHA+. [Icterícia leve]. Avaliar sinais de

■ PS / Sala — Prescrição — PS

HEMOGRAMA, PCR, NA, K, UREIA, CREATININA, TGO, TGP, BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES, FA, GAMA GT, AMILASE,
LIPASE, USG ABDOME SUPERIOR
DIETA ZERO
RINGER LACTATO 500ML EV
DIPIRONA 1G EV 6/6H
CETOPROFENO 100MG EV 12/12H
BROMOPRIDA 10MG EV 8/8H
CEFTRIAXONA 2G EV 24/24H
METRONIDAZOL 500MG EV 8/8H
SINAIS VITAIS 6/6H

Colite Pseudomembranosa · CID A04.7

■ Hemograma, uréia, creatinina, sódio, potássio, albumina.

Exame físico

[REG], [febril].
SSVV: PA __/__ | FC __ | FR __ | SatO2 __% | Tax __°C.
Abdome: distendido, dor difusa, RHA+. Diarreia volumosa (uso recente de ATB). Avaliar desidratação e sinais

■ Casa — Prescrição — Casa

METRONIDAZOL 250MG
TOMAR 02 CPS DE 8/8 HORAS POR 10 DIAS
OU VANCOMICINA 125MG
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS POR 10 DIAS

Constipação · CID K59.0 · K59

■ Se não melhorar
Se não melhorar

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Abdome: distendido, timpânico, RHA+, indolor ou dor leve difusa, sem defesa. Toque retal: [fezes endurecidas]

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Plantago ovata Forssk ----- 1 caixa
Diluir 01 envelope em 01 copo de água, uma vez ao dia, até melhora dos sintomas. A dose pode ser repetida d
OU 1) Óleo mineral ----- 1 frasco
Tomar 1 colher de sopa de 12/12h.
OU 1) Lactulose 667 mg/mL ----- 1 frasco
Tomar 15 ml, uma vez ao dia, até melhora dos sintomas. Ajustar conforme resposta, considerando dose máxima
OU 1)Bisacodil 5 mg ----- 1 caixa
Tomar 01 cp de 12 em 12 horas se resistência a outras medidas laxativas.

■ Casa — Prescrição — Casa

PLANTAGO OVATA FORSSK -----
TOMAR 01 ENVELOPE 2X AO DIA
OU POLICARBOFILA CALCICA 625MG -----
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS, JUNTO COM AS REFEIÇÕES
OU ÓLEO MINERAL
TOMAR 20ML DE 12/12 HORAS
LUFTAL 125MG
TOMAR 01 CP DE 4/4 HORAS
DOMPERIDONA 10MG
TOMAR 01 CP 20 MINUTOS DAS REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA)
BROMOPRIDA 10MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, SE NAUSEA OU VOMITO

■ Casa — Prescrição — Casa

POLIETILENOGLICOL 4000 -----
TOMAR 10G DILUIDOS EM AGUA OU SUCO 1X AO DIA
OU LACTULOSE -----
TOMAR 15 ML 1X AO DIA
OU HIDROXIDO DE MAGNESIO 1200MG/15ML -----
TOMAR 30 ML 1X AO DIA

■ Casa — Prescrição — Casa

BISACODIL 5MG-----
TOMAR 01 CP 1X AO DIA

■ Casa — Se intensa

CLISTER GLICERINADO 500ML AGORA

Cólica Biliar · CID K80

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Abdome: dor em hipocôndrio direito/epigástrico, Murphy [negativo – se positivo, pensar colecistite], sem def

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Dipirona 500mg ----- 40 comprimidos
Tomar 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre por 5 dias
OU 1) Paracetamol 750mg ----- 40 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas se dor ou febre por 5 dias
2) Buscopan composto ----- 1 caixa
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas se dor ou cólica.
3) Diclofenaco 50mg ----- 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas se dor intensa por até 5 dias.
4) Tramadol 50mg ----- 12 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se dor muito intensa e resistente aos tratamentos anteriores.
5) Ondansetrona 8mg sublingual ----- 1 caixa
Deixar 1 comprimido abaixo da língua até a absorção completa. Tomar medicação de 8 em 8 horas se náusea ou
OU 4) Metoclopramida 10mg ----- 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se náusea ou vômito.

Disenteria · CID A09

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., [febril].
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Abdome: RHA+ aumentados, dor difusa, sem defesa/DB. Fezes com [sangue/muco]. Avaliar estado de hidratação.

■ Casa — Prescrição — Casa

CIPROFLOXACINO 500MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 3-5 DIAS
OU AZITROMICINA 1G
TOMAR 01 CP, DOSE ÚNICA
OU AZITROMICINA 500MG
TOMAR 01 CP 1X AO DIA POR 3-5 DIAS
E/OU
ALBENDAZOL 400MG
TOMAR 01 CP 1X AO DIA POR 3 DIAS

Diverticulite Aguda · CID K57

■ dieta sem resíduos (leve, sem sementes) (www.gamedii.com.br/especialidades-nutricao/378-dieta-sem-residuos)
HEMOGRAMA, PCR, NA, K, UREIA, CREATININA, TC ABDOME COM CONTRASTE
Não complicada

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., [febril].

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Abdome: dor em FIE, [defesa/Blumberg localizado em FIE], massa palpável dolorosa? RHA+/↓. Avaliar sinais de

■ PS / Sala — Complicada

DIETA ZERO
RINGER LACTATO 500ML EV
CEFTRIAXONA 2G EV 24/24H
METRONIDAZOL 500MG EV 8/8H
DIPIRONA 1G EV 6/6H SN
BROMOPRIDA 10MG EV 8/8H SN
SINAIS VITAIS 6/6H

■ Casa — Prescrição — Casa

CIPROFLOXACINO 500MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS
METRONIDAZOL 250MG
TOMAR 02 CP DE 8/8 HORAS POR 7 DIAS
DIPIRONA 500MG
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR

Doença do Refluxo Gastroesofágico · CID K21

■ manter tratamento por 4-8 semanas, não comer antes de deitar, evitar refeições volumosas, cessar tabagismo, evitar alimentos (café,chocolate, álcool) -----

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Abdome: leve dor epigástrica, sem defesa, RHA+. Orofaringe sem alterações. Sem disfagia/odinofagia, sem sin

■ Casa — Prescrição — Casa

OMEPRAZOL 20MG
TOMAR 02 CP PELA MANHA, 30 MINUTOS ANTES DA REFEIÇÃO
OU PANTOPRAZOL 20MG
TOMAR 01 A 02 CP PELA MANHA
E (não é obrigatório)
DOMPERIDONA 10MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS
OU BROMOPRIDA 10mg
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS
OU HIDROXIDO DE MAGNÉSIO 60MG/ML
TOMAR 5 - 10 ML VO 1 HORA APÓS AS REFEIÇÕES E AO DEITAR

Enterobíase / Oxiurose · CID B80

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

Região perianal: [escoriações por prurido]. Prurido anal de predomínio noturno. Restante do exame sem alter

■ Casa — Prescrição — Casa

ALBENDAZOL 400MG
TOMAR (10mg/kg - máximo 400mg) 1X AO DIA POR 3 DIAS
DIPIRONA 1G
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE
HIDROXIZINA 25MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, SE COCEIRA

Epigastralgia / Pirose · CID R10.1

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Abdome: dor à palpação em epigástrio, sem defesa/DB, RHA+. Sem massas. Sem sinais de alarme (sem melena, se

■ Casa — Prescrição — Casa

HIDROXÍDO DE ALUMÍNIO -----

TOMAR 15 ML 3X AO DIA, 15 MINUTOS ANTES DAS PRINCIPAIS REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA)

DIPIRONA 500MG -----

TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR

OU HIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO + SIMETICONA

TOMAR 10ML 4X AO DIA, 1 HORA ANTES DAS REFEIÇÕES1) Buscopan Composto

Tomar 01 comprimido de 08/08 horas se dor

2) Ondansetrona 4mg

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS SE NAUSEA

3) OMEPRAZOL 20MG -----

TOMAR 01 CP 1X AO DIA, PELA MANHÃ, POR 10 DIAS

3) LUFTAGASTRO PRO

Tomar 01 sachê se sintomas de azia e má digestão

4) Dexilant 30 mg

Tomar 1 comprimido pela manhã, por 30 dias.

Gastrite / DRGE · CID K29

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Abdome: dor à palpação em epigástrio, sem defesa/DB, RHA+. Sem massas nem visceromegalias.

■ Casa — Prescrição — Casa

x) Omeprazol 20mg -----28 comprimidos

Tomar 2 comprimidos, uma vez ao dia, em jejum e aguardar 30 minutos para se alimentar por 14 dias.

x) Pepsamar (HIDRÓXIDO DE ALUMINIO) 230mg ----- 1 caixa

Mastigar 2 comprimidos ao sentir azia intensa.

GECA / Gastroenterite (adulto) · CID A09

■ PACIENTE REFERE DIARREIA HÁ DIA. Nega febre, nega sangue nas fezes, nega vômitos persistentes, nega incapacidade de ingerir líquidos, nega redução da diurese, nega tontura, nega síncope, nega dor abdominal intensa, nega distensão abdominal e nega prostração importante.

#MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO: NEGA

#COMORBIDADES PRÉVIAS: NEGA

#ALERGIAS: NEGA ALERGIAS MEDICAMENTOSAS CONHECIDAS.

#Possibilidade de estar gestante:

#EXAME FÍSICO:

Bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril

Abdome discretamente distendido, plano, dor discreta à palpação difusamente, sem defesa ou rigidez.

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., mucosas úmidas.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Abdome: RHA+ (aumentados), flácido, dor difusa leve à palpação, sem defesa/rigidez, DB negativa. Sem sinais

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Soro de hidratação oral ----- 4 sachês

Diluir 1 sachê em 1L de água filtrada e tomar um copo a cada novo episódio de evacuação. Armazenar em gelad

2) Dipirona 500mg ----- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas se dor ou febre.

3) Buscopan composto ----- 1 caixa

Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas se dor ou cólica.

4) Metoclopramida 10mg ----- 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se náusea ou vômito.

OU 4) Ondansetrona 4mg sublingual ----- 1 caixa

Deixar 1 a 2 comprimidos abaixo da língua até dissolver. Tomar de 8 em 8 horas se náusea ou vômito.

5) Floratil ----- 1 caixa

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 3 dias.

6) RACECADOTRILA 100MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, por até 3-5 dias ou até cessar diarreia, associado a hidratação oral.

7) SIMETICONA GOTAS ----- 01 FRASCO

TOMAR 50 GOTAS DE 8/8H, SE GASES.

SE EPIGASTRALGIA

Omeprazol 20mg -----28 comprimidos

Tomar 1 comprimido, uma vez ao dia, em jejum e aguardar 30 minutos para se alimentar por 14 dias.

■ Casa — SE PRECISAR DE ATB

1) Ciprofloxacino 500mg ----- 6 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 3 dias.

OU 2) Sulfametoxazol-trimetoprima 800-160mg

Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas por 3 a 5 dias.

■ Casa — Prescrição — Casa

BUSCOPAN COMPOSTO
TOMAR 1 CP VO DE 8/8H SE DOR ABDOMINAL
DRAMIN B6
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H, SE NÁUSEAS OU VÔMITOS.
SORO DE REIDRATAÇÃO ORAL ----- 3 ENVELOPES
DISSOLVER 1 ENVELOPE EM 1 LITRO DE AGUA FILTRADA. TOMAR PEQUENAS QUANTIDADES VÁRIAS VEZES AO DIA.
FLORATIL 200 MG
DILUIR 1 SACHÊ EM ÁGUA CONFORME BULA E TOMAR DE 12/12 H POR 3 DIAS.
SIMETICONA 40MG
TOMAR 1 CP VO DE 8/8H, SE GASES
RACECADOTRILA 100MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, ATÉ CESSAR A DIARREIA
Se < 5 anos: DAR ZINCO 20MG/ DIA POR 10 DIAS
Se < 6 meses: DAR ZINCO 10MG/DIA POR 10 DIAS

Hemorragia Digestiva Alta · CID K92.2

Exame físico

[REG/MEG, palidez].
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C. (avaliar hipotensão postural).
Toque retal: MELENA. [Hematêmese/borra de café]. Estigmas de hepatopatia? Avaliar repercussão hemodinâmica

■ PS / Sala — Prescrição — PS

MONITORIZAÇÃO
DIETA ZERO
RINGER LACTATO 500ML EV AGORA (20-30ml/kg de ressuscitação)
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS, se necessário (HB <7)
NORADRENALINA: 4 AMP + 254ML SG5% EV EM BIC - INICIAR 5-10ML/H (Alvo PAM < 65), se necessário
SVD - quantificar diurese (Meta: 0,5ml/kg/hora)
SOLICITAR EDA
SOLICITAR UTI

■ PS / Sala — HDA Varicosa

CEFTRIAXONA 2G EV AGORA
TERLIPRESSINA 2MG EV AGORA

■ PS / Sala — HDA Não varicosa

OMEPRAZOL 40MG EV AGORA (manter de 12/12 horas)

Hemorroida · CID I84

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., afebril.
Região anal: [mamilo hemorroidário externo trombosado / plicoma], sem abscesso/celulite perianal. Toque ret

■ Casa — Prescrição — Casa

PLANTAGO OVATA (METAMUCIL/FIBERMAIS/MUVINLAX) -----
TOMAR 1 A 3 SACHES, DILUIDOS EM 200ML DE AGUA
E/OU
LACTULOSE -----
TOMAR 15ML DE 8/8 HORAS
DIPIRONA 500MG -----
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR
CETOPROFENO 100MG -----
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 3-5 DIAS

■ Casa — Prescrição — Casa

XYLOPROCT POMADA -----
APLICAR FINA CAMADA VARIAS VEZES AO DIA NA AREA AFETADA
OU XYLOPROCT POMADA -----
UTILIZAR O APLICADOR PARA APLICAR MEDICAÇÃO
OU HIDROCORTISONA CREME 10MG/G -----
APLICAR FINA CAMADA NA REGIÃO AFETADA 2 A 3 VEZES POR DIA, POR NO MÁXIMO, 2 SEMANAS
BANHO DE ASSENTO -----
SENTAR EM BACIA COM AGUA MORNA E PERMANECER POR 15 MINUTOS, 2 VEZES POR DIA

Pancreatite Aguda · CID K85

Exame físico

[REG/MEG].
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Abdome: dor epigástrica intensa em faixa/irradiação dorsal, [distensão], RHA↓. [Sinais de Cullen/Grey-Turner]

■ PS / Sala — Prescrição — PS

HEMOGRAMA, FA, GAMA GT, TGO, TGP, BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES, AMILASE, LIPASE, PCR, GLICEMIA, NA, K,
USG ABDOMINAL E/OU TC ABDOME

DIETA ZERO (até melhora clínica)
RINGER LACTATO 1000ML EV AGORA
RINGER LACTATO 500ML + 7 AMP (10ML) GLICOSE HIPERTÔNICA 50% + 1 AMP (10ML) KCL 8/8 HORAS
DIPIRONA 1G EV 6/6 HORAS
CETOPROFENO 100MG 12/12H EV
MORFINA 2MG/ML: 2-4ML 4/4H, SE NECESSÁRIO
ONDANSETRONA 4MG/ML 8/8H EV
SVD – quantificar diurese (ideal: >0,5ml/kg/h)
SINAIS VITAIS 6/6H

Parasitose

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Abdome: flácido, RHA+, [dor difusa leve]. Avaliar palidez (anemia), prurido anal. Geralmente exame pobre; c

■ Casa — Prescrição — Casa

ALBENDAZOL 200MG
TOMAR 02 COMPRIMIDOS, DOSE ÚNICA

Solução · CID R06.6

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Solução persistente. Exame geralmente normal – investigar causa (refluxo, irritação diafragmática, SNC, dist

■ Casa — Prescrição — Casa

CLOPROMAZINA 25MG
TOMAR 01 A 02 CPS DE 12/12 HORAS POR 5 A 10 DIAS
OU GABAPENTINA 300MG
TOMAR ½ CP DE 8/8 HORAS POR 5 A 10 DIAS
OU BROMOPRIDA 10MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 5 A 10 DIAS
OU BACLOFENO 10MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 5 A 10 DIAS

Xerostomia · CID R68.2

■ consumir acerola, limão, maçãs, peras; umedecer cavidade oral com água filtrada ou gelo

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Cavidade oral: mucosa seca, saliva escassa/espessa, [candidíase associada, cáries]. Avaliar medicações xero

■ Casa — Prescrição — Casa

GOMA DE MASCAR SEM AÇÚCAR
E/OU
PILOCARPINA 4% 40MG/ML
APLICAR 3 GOTAS 3X AO DIA, DURANTE OU APÓS AS REFEIÇÕES
E/OU
SALIVA ARTIFICIAL KIN-HIDRAT
USAR DE ACORDO COM NECESSIDADE
E/OU
DEXPANTENOL
APLICAR NOS LÁBIOS 2-3X AO DIA

■ Renal / Endócrino / Metabólico

Cetoacidose Diabética · CID E14.1

Exame físico

[REG/MEG], desidratado, [rebaixado].
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Ritmo de Kussmaul, hálito cetônico. Mucosas secas, TEC alargado. Glicemia capilar ___ (>250). Buscar fator p

■ PS / Sala — Após resultado de exames

Na normal-alto: NaCl 0,45% 250-500ML/HORA
Na baixo: NaCl 0,9% 250-500ML/HORA
Quando glicemia = 200: SORO GLICOSADO 5% + NaCl 0,45% 150-250ML/HORA
K <3,3: CLORETO DE POTÁSSIO 10% (1G/10ML) 10ML + NaCl 0,45% 100ML – ADMINISTRAR 20-40 mEq/HORA ATÉ K
>3,3 – NÃO DAR INSULINA
K ENTRA 3,3 E 5,5: DE POTÁSSIO 10% (1G/10ML) 10ML + NaCl 0,45% 100ML – ADMINISTRAR 20-30 mEq EM CADA
LITRO DE FLUIDO EV
K > 5,5: DOSAR NOVAMENTE EM 2 HORAS

Se pH <6,9: BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% (1mEq/ML) 100ML + SF0,9% 400ML - CORRER EM 2 HORAS

■ **PS / Sala — Paciente leve-moderado**

INSULINA REGULAR (100UI/ML): 0,3 UI/KG SC DOSE ÚNICA
APÓS: 0,2 UI/KG SC DE 2/2 HORAS
Quando glicemia = 200: 0,1 UI/KG SC 2/2HORAS
DIPIRONA 1G EV DE 6/6HORAS
BROMOPRIDA 10MG EV DE 8/8HORAS
O2 SE NECESSÁRIO
GLICEMIA CAPILAR 1/1 HORAS - se valores estáveis por 3 horas, fazer de 2/2 horas
UREIA, CREATININA, NA, K DE 2/2 HORAS - até estabilização
INTERNAR

■ **Casa — Prescrição — Casa**

DEXTRO, GASOMETRIA ARTERIAL, URINA 1, NA, K, HEMOGRAMA, UREIA, CREATININA, ECG
DIETA ZERO
15-20ML/KG SF0,9% NA PRIMEIRA HORA

■ **Internação — Paciente grave**

INSULINA REGULAR (100UI/ML): 1ML + 99ML SF0,9% (Concentração: 1 unidade/ml) - ADMINISTRAR 0,1 UI/KG EM BOLUS
APÓS: 0,1 UI/KG/HORA EV EM BI - TITULAR RESPOSTA
Quando glicemia = 200: 0,02 - 0,05 UI/KG/HORA EV

Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar · CID E14

Exame físico

[Rebaixado], desidratação grave.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Mucosas muito secas, TEC alargado, [hipotensão]. Glicemia capilar ___ (muito alta, >600). Sem Kussmaul/cetos

■ **PS / Sala — Após resultado de exames**

Na normal-alto: NaCl 0,45% 150-250 ML/HORA
Quando glicemia = 300: SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 150 ML + SF 150 ML - infundir 150 ml/hora
K <3,3: CLORETO DE POTÁSSIO 10% (1G/10ML) 10ML + NaCl 0,45% 100ML - ADMINISTRAR 20-40 mEq/HORA ATÉ K >3,3 - NÃO DAR INSULINA
K ENTRA 3,3 E 5,5: DE POTÁSSIO 10% (1G/10ML) 10ML + NaCl 0,45% 100ML - ADMINISTRAR 20-30 mEq EM CADA LITRO DE FLUIDO EV
K > 5,5: DOSAR NOVAMENTE EM 2 HORAS
INSULINA REGULAR (100UI/ML): 1ML + 99ML SF0,9% (Concentração: 1 unidade/ml) - ADMINISTRAR 0,1 UI/KG EM BOLUS
APÓS: 0,1 UI/KG/HORA EV EM BI - TITULAR RESPOSTA
Quando glicemia = 300: 0,5 A 1,0 UI/HORA EV
DIPIRONA 1G EV DE 6/6HORAS
BROMOPRIDA 10MG EV DE 8/8HORAS
GLICEMIA CAPILAR 1/1 HORAS - se valores estáveis por 3 horas, fazer de 2/2 horas
UREIA, CREATININA, NA, K DE 2/2 HORAS - até estabilização
INTERNAR

■ **Casa — Prescrição — Casa**

DEXTRO, GASOMETRIA ARTERIAL, URINA 1, NA, K, HEMOGRAMA, UREIA, CREATININA, ECG
DIETA ZERO
SF0,9% 15-20ML/KG NA PRIMEIRA HORA

Hiperglicemia · CID R73.9

■ - Insulina Regular SC:

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Glicemia capilar ___. Avaliar sintomas (poliúria, polidipsia), sinais de desidratação, cetose (afastar CAD/E

■ **Casa — GLICEMIA CAPILAR**

Glicemia 150-250: 2UI
Glicemia 250-300: 4UI
Glicemia 300-350: 6UI
Glicemia 350-400: 8UI
Glicemia >400: 10U
Cuidado com CAD e EHH!

Hiperpotassemia · CID E87.5

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril. (sintomas inespecíficos).
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Avaliar fraqueza muscular, [arritmia]. ECG obrigatório: onda T apiculada, alargamento de QRS, ↓onda P. K sé

■ **PS / Sala — Se ECG alterado**

GLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML + SG5% 100ML EV EM BIC EM 2-3 MIN

INSULINA REGULAR 10 UI + SG10% 500ML EV EM BIC EM 60 MINUTOS
OU NEBULIZAÇÃO COM SALBUTAMOL: 10 GOTAS + 3ML SF - REPETIR ATÉ 3X
OU FUROSEMIDA (20MG/2ML): 1 AMP DE 12/12 H

Hipoglicemia · CID E16.2

Exame físico

[Sudoreico/rebaixado/agitado].

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Glicemia capilar ___ (<70). Sinais adrenérgicos (tremor, sudorese, taquicardia) e neuroglicopênicos (confusão)

■ PS / Sala — Prescrição — PS

GLICOSE HIPERTÔNICA 50%: 4 A 6 AMP EV (começar com 4)

Caso não conseguir acesso venoso (incomum): GLUCAGON 1MG IM

Hepatopatas, etilistas, desnutridos: TIAMINA 100MG EV

■ Casa — Prescrição — Casa

LEVE (55-70 MG/DL):

■ Casa — Prescrição — Casa

1) GH 50% ----- 1 FRASCO

DILUIR DE 30-40ML EM ÁGUA, SUCOS, REFRIGERANTES E OUTROS LÍQUIDOS

BEG, CHAAA, LOTE

NEURO: GLASGOW 15, PUPILAS ISOFOTORREAGENTES, SEM DEFECTS FOCAIS, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENINGEA.

ACV: 2 BRNF, SEM SOPROS AUDIVEIS

AR: MV + BILATERALMENTE, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS

ABD: FLACIDO, INDOLOR A PALPAÇÃO, RHA+, AUSÊNCIA DE VICEROMEGALIAS E MASSAS PALPAVEIS.

MEMBROS: SEM EDEMA, SEM DOR A PALPAÇÃO, SEM SINAIS DE TVP. TEC MENOR QUE 3 SEGUNDOS. PULSOS

PRESENTES, AMPLOS E SIMÉTRICOS BILATERALMENTE

OROSCOPIA: SEM ALTERAÇÕES

OTOSCOPIA: MT TRANSPARENTE, SEM ABAULAMENTOS

PRESCREVO SINTOMÁTICOS EM UNIDADE

PRESCREVO SINTOMÁTICOS PARA DOMICÍLIO

ORIENTO SINAIS DE ALARME E RETORNO SE NECESSÁRIO

TRATO DIGESTIVO

Hiponatremia · CID E87.1

■ Grave (<120) e aguda:

Exame físico

[Variável conforme gravidade/velocidade].

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Avaliar volemia (hipo/eu/hipervolêmica): mucosas, TEC, edema, turgência. Neuro: [confusão, cefaleia, convulsões]

■ Casa — Prescrição — Casa

SF 0,9% 445 ML + NaCl 20% 55ML - INFUNDIR EM BI DURANTE 12 HORAS

SOLICITAR NA APÓS

Hipopotassemia · CID E87.6

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Fraqueza muscular, [cãibras], [íleo]. ECG: onda U, achatamento de T, [ESV]. K sérico ___. Buscar causa (perda)

■ Casa — Leve

KCL XAROPE 6%

TOMAR 15ML VO DE 8/8 HORAS

OU CLORETO DE POTÁSSIO 600MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS

Moderado/grave (K < 3)

KCL 19,1% 15 ML (1,5 ampola) + SF 0,9% 1 LITRO - EV EM BIC 250 ML/H POR 4 HORAS

Rabdomiólise · CID M62

■ SF OU RINGER LACTATO MONITORAR DÉBITO URINÁRIO CORREÇÃO DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS (Hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia).

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Mialgia, fraqueza, urina escura (mioglobinúria - 'cor de coca-cola'). [Edema/dor muscular localizada]. Buscar

■ Casa — Prescrição — Casa

HEMOGAMA, UREIA, CREATININA, FOSFORO, POTÁSSIO, CÁLCIO, TGO, TGP, GGT, GLICOSE, ÁCIDO ÚRICO, GASOMETRIA VENOSA, CPK, URINA I, ECG

CPK < 3000 sem disfunção renal:

HIDRATAÇÃO + CPK DIARIAMENTE

CPK > 5000 e lesão renal:

■ Hematologia

Anemia Ferropriva · CID D50.9

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Palidez cutâneo-mucosa, [coiloníquia, queilite angular]. ACV: [sopro sistólico funcional]. Investigar fonte

■ Casa — Prescrição — Casa

SULFATO FERROSO (200MG FERRO ELEMENTAR) -----

TOMAR 01 CP 1X AO DIA, TOMAR 30 MINUTOS ANTES OU 60 MINUTOS DAS REFEIÇÕES. DE PREFERENCIA JUNTO COM SUCO DE LARANJA

Anemia Megaloblástica · CID D51

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Palidez, [glossite, icterícia leve]. Neuro (B12): [parestesias, ↓propriocepção, marcha atáxica]. Investigar

■ PS / Sala — Vitamina B12

USO INTRAMUSCULAR

CIANOCOBALAMINA 2500 MCG/ML -----

APLICAR 5000 MCG IM A CADA 7 DIAS POR 4 SEMANAS.

APÓS, 5000MCG IM A CADA 30 DIAS, POR 2 MESES.

OU

■ Casa — Prescrição — Casa

CIANOCOBALAMINA 1000MCG -----

TOMAR 01 CP 1X AO DIA

Ac fólico

■ Casa — Prescrição — Casa

ACIDO FOLICO 5MG -----

TOMAR 01 CP 1X AO DIA

Crise Álgica Falcêmica · CID D57

Exame físico

[REG por dor].

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Dor óssea/articular difusa, [priapismo]. Avaliar sinais de complicação: síndrome torácica aguda (dor toráci

■ PS / Sala — Prescrição — PS

- SF 0,9% 500ml (3 a 5L/24h)

- Leve: Dipirona 1g EV

- Moderada: Tramadol 100mg + 100ml SF 0,9 + bromoprida EV lento

- Intensa: Morfina (2mg/2ml) 2ml repetir em 5min, se não melhorar.

■ Casa — Síndrome Torácica Aguda

- SF 0,9% 2 a 3L/24h

- Se sat <90%: O2

- Ceftriaxona 2g 1x/dia EV + Azitromicina 500mg 1x/dia VO

Epistaxe · CID R04.0

■ - Avaliar sinais de trauma -> ABCD, exame de imagem

- Avaliar uso de AAS, Clopidogrel, Marevan/ HAS descontrolada

- Manter paciente sentado com cabeça levemente fletida

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ (avaliar HAS/repercussão).

Rinoscopia: sangramento [anterior – Kiesselbach / posterior]. Avaliar uso de anticoagulante/antiagregante,

■ PS / Sala — Prescrição — PS

- Preparar tampão anterior: gaze + pinça kelly +1 amp adrenalina (ou ácido tranexâmico 50mg/ml 5 a 10ml) + xylocaina gel

- Se não melhorar: ácido tranexâmico 1 amp + 250ml SF 0,9% correr em 10 a 30 min

- Deixar em observação e encaminhar para especialista

Neutropenia Febril · CID D72.9

■ Hemograma, função renal, eletrólitos, função hepática, PCR, lactato, hemocultura.
MASCC SCORE p/ saber onde tratar.

Exame físico

[REG/MEG], febril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Buscar foco minucioso (cavidade oral, pele/cateter, perianal – evitar toque retal, pulmonar, urinário). Sin

■ PS / Sala — Ambulatorial

CEFEPIME 2G EV 8/8 HORAS OU

■ Casa — Prescrição — Casa

AMOXICILINA + CLAVULANATO 875/125MG

TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS

CIPROFLOXACINO 500MG

TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS

OU

■ Casa — Prescrição — Casa

LEVOFLOXACINO 500MG

TOMAR 01 CP 1X AO DIA

■ Internação — Internação

CEFEPIME 2G 8/8 HORAS

OU MEROPENEM 1G 8/8 HORAS

OU TAZOCIN 4,5G 6/6 HORAS

Se presença de infecção cutânea, acrescentar: VANCOMINA 2G 8/8 HORAS

Se diarreia por Clostridium: VANCOMINA 500MG VO

Transfusão de Hemoderivados

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Avaliar indicação e alvo (Hb/plaquetas/coagulação). Durante: monitorar febre, calafrio, dispneia, urticária

■ PS / Sala — HEMÁCIAS

CONCENTRADO DE HEMÁCIAS (1 unidade aumenta 1 hb e 3% ht) – nos primeiros 30 minutos, 15 gotas/minuto (média 1-2 horas)

DIPIRONA 500MG – 1G EV DE 6/6 HORAS

METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML – 1 AMP EV

■ PS / Sala — Se histórico de reação alérgica

DIFENIDRAMINA 50MG/ML – 10-50MG IM PROFUNDA OU EV EM 5-30 ,OMITOS

OU PROMETAZINA 25MG/ML – 1 AMP IM

Dosar Hb/Ht em 1-2 horas

PLAQUETAS

CONCENTRADO DE PLAQUETAS (50-60ml/bolsa) – 1 UNIDADE/10KG – INFUNDIR EM 30 MINUTOS

DIPIRONA 500MG – 1G EV DE 6/6 HORAS

METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML – 1 AMP EV

SISTEMA UROGENITAL

■ MSK / Reumato / Orto

Dor Crônica · CID R52.2

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Exame do sítio doloroso: [articular/miofascial/neuropático]. Amplitude de movimento, pontos-gatilho, sinais

■ Casa — Prescrição — Casa

1. Dipirona sódica 500 mg – 40 COMPRIMIDOS

Tomar 2 comprimidos por via oral a cada 6 horas, em horários fixos (6h – 12h – 18h – 00h).

Não usar "só se doer" – tomar regularmente para manter nível analgésico constante. Máx. 4 g/dia.

2. Naproxeno 500 mg - 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido por via oral a cada 12 horas, junto com alimento ou leite, por no máximo 5 dias. Não tom

OU (idoso, HAS)

2. Celecoxibe 200 mg – caixa com 10 cápsulas

Tomar 1 cápsula por via oral 1 vez ao dia.

3. Diclofenaco gel 1% tópico - Bisnagas 60 g

Aplicar 2-3 g (um fio de 5 cm aprox.) sobre a articulação dolorosa, esfregando suavemente, 3 a 4 vezes ao d

Lavar as mãos após aplicação. Não aplicar em pele ferida ou mucosas.

4. Gabapentina 300 mg - caixa com 30 cápsulas

Iniciar com 1 cápsula à noite por 7 dias. Após, aumentar para 1 cápsula de 8 em 8 horas (manhã, tarde e noi

Pode causar sonolência no início – por isso começa à noite. O efeito na dor aparece após 2-3 semanas de uso

ATENÇÃO - TRAMADOL SAO 2 VIAS

5. Tramadol 50 mg – caixa com 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido por via oral a cada 8 horas, somente nos dias de dor intensa. Não usar de forma contínua.
Reservar para crises fortes.

■ Casa — (Bia) PARA DOR ARTICULAR

1. Sulfato de glucosamina 1500 mg + sulfato de condroitina 1200 mg
Tomar 1 sachê ao dia, dissolvido em água, junto com refeição.

Entorse do Tornozelo · CID S93.4

■ - Gelo local 5x/ dia por 20 minutos - Imobilização durante 1-2 semanas - Elevação do membro - Repouso relativo

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Tornozelo [D/E]: edema e dor em [maléolo lateral/ligamento talofibular anterior], equimose. Carga [possível]

■ Casa — Prescrição — Casa

DIPIRONA 500MG -----
TOMAR 01 A 02 CPS DE 6/6 HORAS, SE DOR
CETOPROFENO 100MG -----
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 5 DIAS
OU IBUPROFENO 600MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 5 DIAS

■ Casa — Se dor intensa

TRAMADOL 100MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, SE DOR INTENSA

Fasciíte Plantar · CID M72.2

■ - Alongamento - Modificar calçados (bom amortecimento) - Perda ponderal - Calor local 4x ao dia, 20 min/vez

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Pé [D/E]: dor à palpação da inserção da fáscia plantar no calcâneo, pior aos primeiros passos matinais. Dor

■ Casa — Prescrição — Casa

CETOPROFENO 100MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS
DIPIRONA 500MG
TOMAR 01 A 02 CPS DE 6/6 HORAS, SE DOR

Gota · CID M10

■ CRISE AGUDA
PROFILAXIA

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Articulação [1ª MTF/jelho/tornozelo]: monoartrite com sinais flogísticos (edema, calor, rubor, dor intensa)

■ Casa — Prescrição — Casa

NAPROXENO
TOMAR 1CP DE 12/12 HORAS POR 5 DIAS
OU IBUPROFENO 600MG -----
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 5 DIAS
OU PREDNISONA 20MG -----
TOMAR 01CP 1X AO DIA POR 5 DIAS
OU COLCHICINA 0,5MG -----
TOMAR 02 CPS. APÓS 1 HORA, TOMAR 01 CP. EM SEGUIDA, TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS
AGORA: PROFENID 1AMP IM

■ Casa — Prescrição — Casa

ALOPURINOL 100MG
TOMAR 01 CP 1X AO DIA

Insuficiência Venosa Crônica · CID I87.2

■ elevação dos membros inferiores por 30 min 3x ao dia, pratica de atividade física, meia de compressão elástica.

Se presença de ulcera
Se dermatite de contato
TRIANCINOLONA PASSAR NA LESÃO 2X AO DIA, ATÉ MELHORA DA LESÃO OU BETAMETASONA PASSAR NA LESÃO 2X AO DIA, ATÉ MELHORA DA LESÃO

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
MMII: varizes, edema vespertino, dermatite ocre, [lipodermatosclerose, úlcera maleolar medial]. Pulsos dist

■ Casa — Prescrição — Casa

DIOSMINA + HESPERIDINA 450+50MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS

■ Casa — Prescrição — Casa

PENTOXIFILINA 400MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS, ATÉ CICATRIZAÇÃO

Lombalgia / Mialgia · CID M54.5 · M79.6

■ PACIENTE REFERE LOMBALGIA, HÁ DIAS. Dor pior ao movimento e melhora com repouso. Nega Irradiação. Nega trauma. Nega febre. Nega sintomas urinários. Nega perda de força ou anestesia. Nega uso prévio de medicações para o quadro.

#MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO: NEGA

#COMORBIDADES PRÉVIAS: NEGA

#ALERGIAS: NEGA ALERGIAS MEDICAMENTOSAS CONHECIDAS.

#EXAME FÍSICO:

Bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril

Coluna lombar discretamente dolorosa à palpação paravertebral, sem deformidades perceptíveis. Mobilidade normal, com dor que piora ao movimento.

Sem déficits neurológicos em MMII.

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Coluna lombar: dor à palpação de musculatura paravertebral, sem dor em linha média/processos espinhosos. La

■ Casa — Prescrição — Casa

1) DIPIRONA 500MG ----- 40 comprimidos

Tomar 2 comprimidos por via oral a cada 6 horas, se dor

OU 1) Dipirona sódica 500 mg – 40 COMPRIMIDOS

Tomar 2 comprimidos por via oral a cada 6 horas, em horários fixos (6h – 12h – 18h – 00h).

Não usar "só se doer" – tomar regularmente para manter nível analgésico constante. Máx. 4 g/dia.

2) Naproxeno 500 mg - 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido por via oral a cada 12 horas, junto com alimento, por no máximo 5 dias. Não tomar com es
ou

■ Casa — Prescrição — Casa

1) DIPIRONA 500MG ----- 40 comprimidos

Tomar 2 comprimidos por via oral a cada 6 horas, se dor

2) Cetoprofeno 100 mg - 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido por via oral a cada 12 horas, junto com alimento, por no máximo 5 dias. Não tomar com es
ou

Diclofenaco 50mg ----- 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 5 dias.

3)CICLOBENZAPRINA 5MG -----

TOMAR 01 COMPRIMIDO 30 MIN ANTES DE DORMIR, POR 5 DIAS. Antes de dormir porque pode dar sono

■ Casa — 2VIAS RECEITA

TRAMAL RETARD 100MG ----- 1 CAIXA

TOMAR 01 CP DE 6/6H SE DOR INTENSA.

PARACETAMOL+CODEÍNA 500+30MG ----- 01 CAIXA

TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H SE DOR INTENSA.

Osteoartrite · CID M19

■ perda de peso, atividade física _____ NEUROLOGIA

DICLOFENACO GEL APLICAR FINA CAMADA EM ARTICULAÇÃO ACOMETIDA 3X AO DIA OU NIMESULIDA GEL APLICAR FINA CAMADA EM
ARTICULAÇÃO ACOMETIDA 2X AO DIA

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

Articulação [joelho/mãos/quadril]: dor mecânica, crepitação, [nódulos de Heberden/Bouchard], limitação de A

■ Casa — Prescrição — Casa

DIPIRONA 500MG

TOMAR 01 A 02 CPS DE 6/6 HORAS, SE DOR

E/OU

DICLOFENACO 25MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 5 DIAS

OU TRAMAL 100MG

TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR INTENSA

OU DULOXETINA 30MG

TOMAR 01 CP POR DIA POR 7 DIAS. APÓS, TOMAR 02 CPS POR DIA.

Genitourinário / Gineco

Atrofia Urogenital · CID N90

■ Checar contraindicações

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.

Exame genital: mucosa vaginal pálida, fina, ressecada, [perda de rugosidade, petéquias]. Contexto de pós-me

■ Casa — Prescrição — Casa

ESTRADIOL 10MCG/COMPRIMIDO
APLICAR 1 COMPRIMIDO VIA VAGINAL 2X NA SEMANA
OU

■ Casa — Prescrição — Casa

PROMESTRIENO CREME VAGINAL 10MG
APLICAR A NOITE POR 30 NOITES

Bacteriúria Assintomática · CID N39

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., ASSINTOMÁTICO.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Sem disúria/polaciúria/dor lombar. Giordano negativo. Urocultura positiva sem sintomas. (Tratar apenas gest

■ Casa — Prescrição — Casa

NITROFURANTOINA 100MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 5-7 DIAS
OU AMOXICILINA 500MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 5-7 DIAS
OU FOSFOMICINA 3G
TOMAR 1X, DOSE ÚNICA]

Balanite · CID N51.2

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Glânde/prepúcio: eritema, edema, [secreção, placas esbranquiçadas se candidiásica]. Avaliar fimose/higiene,

■ Casa — Prescrição — Casa

NITRATO DE MICONAZOL CREME 2% -----
APLICAR NAS LESOES 2X AO DIA
HIDROCORTISONA 1% CREME -----
APLICAR NAS LESOES 2X AO DIA
OU FLUCONAZOL 150MG -----
TOMAR 01 CP DOSE UNICA

■ Casa — Prescrição — Casa

DIPIRONA 500MG -----
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR
DESLOXATADINA 5MG -----
TOMAR 01 CP 1X AO DIA, SE COCEIRA

Cancro Mole · CID A57

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Genital: úlcera(s) DOLOROSA(S), fundo sujo/purulento, bordas irregulares e amolecidas. Adenopatia inguinal

■ Casa — Rx USO ORAL

1- AZITROMICINA 500 MG _____ 02 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS VO EM DOSE ÚNICA
EVITAR ROUPAS JUSTAS E DE MATERIAL SINTÉTICO (EX: CALCINHA DE RENDA)
NÃO UTILIZAR PERFUMES DE VULVA
EVITE DUCHAS VAGINAIS
NÃO UTILIZE SABONETES COMUNS PARA LAVAR A REGIÃO GENITAL, OPTE POR SABONETES ÍNTIMOS
ACOSTUME-SE A DORMIR SEM CALCINHA

■ Casa — Prescrição — Casa

AZITROMICINA 500MG ----- 02 CPS
TOMAR 02 CPS, DOSE ÚNICA

Candidíase · CID B37 · B37.9

■ MICONAZOL CREME 2% ----- 1 APLICADOR INTRAVAGINAL A NOITE POR 7 NOITES OU
Candidíase recorrente

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.
Exame especular: corrimento branco grumoso ('leite talhado'), aderido, hiperemia/edema vulvovaginal, prurid

■ Casa — Prescrição — Casa

1)FLUCONAZOL 150 MG ----- 01 COMPRIMIDO
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DOSE ÚNICA
OU 1)MICONAZOL 2% CREME ----- 07
APLICADORES USO: 01 APLICADOR CHEIO, VIA VAGINAL, 01 VEZ POR DIA, POR 7 DIAS

*NAO DAR FLUCONAZOL PARA GESTANTE!

■ Casa — Prescrição — Casa

FLUCONAZOL 150MG -----
TOMAR 01 CP, DOSE ÚNICA

■ Casa — Prescrição — Casa

FLUCONAZOL 150MG -----
TOMAR 01 CP A CADA 3 DIAS, POR 3 DOSES. EM SEGUIDA, TOMAR 01 CP POR SEMANA, POR 6 MESES

Cervicite · CID N72

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.
Especular: colo hiperemiado, friável, com secreção mucopurulenta no orifício. Dor à mobilização do colo? (a

■ Casa — Prescrição — Casa

CEFTRIAXONA 250MG IM DOSE ÚNICA
AZITROMICINA 1G -----
TOMAR 01 CP DOSE ÚNICA

Cistite / ITU · CID N30 · N39

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Abdome: dor leve à palpação suprapúbica, sem defesa. Giordano NEGATIVO bilateral. Sem toxemia.

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Nitrofurantoína 100mg ----- 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas por 5 dias.
OU 1) Fosfomicina 3g ----- 1 envelope
Diluir o envelope em meio copo e tomar em dose única antes de dormir.
OU 1) Cefalexina 500mg ----- 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas por 5 dias.

■ Casa — 2ª LINHA ALTERNATIVA

1)ciprofloxacino 500 mg ----- 20 comprimidos
tomar 1 cp de 12 em 12 horas por 5 dias
2) Pyridium 100mg > fica laranja!
Tomar 1 cápsula de 12 em 12 horas até alívio dos sintomas
2) Dipirona 500mg ----- 40 comprimidos
Tomar 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre por 5 dias
OU 2) Paracetamol 750mg ----- 20 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas se dor ou febre.

■ Casa — Prescrição — Casa

NITROFURANTOINA 100MG -----
TOMAR 01 CP DE 6/6HORAS POR 7 DIAS
OU FOSFOMICINA 3G -----
TOMAR 1 ENVELOPE, DOSE ÚNICA
OU AMOXICILINA + CLAVULANATO 500/125MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 7 DIAS
DIPIRONA 500MG -----
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE
PYRIDIUM 200MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, APÓS AS REFEIÇÕES, POR NO MÁXIMO, DOIS DIAS

Climatério Sintomas Vasomotores · CID N95.1

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Exame geral sem alterações agudas. Contexto de peri/pós-menopausa (fogachos, sudorese, insônia). Avaliar si

■ Casa — Prescrição — Casa

ISOFLAVONA DE SOJA 200MG ----- 1CX
TOMAR 1 CP VO DE 24/24H POR 30 DIAS.

Cólica Menstrual ou Sangramento · CID N94

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Abdome: dor à palpação em hipogástrio, sem defesa/DB. Sem massas palpáveis. [Especular/toque conforme indic

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Dipirona 500mg ----- 40 comprimidos
Tomar 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre por 5 dias

OU 1) PARACETAMOL 500mg ----- 40 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas se dor ou febre por 5 dias
2) Buscopan composto ----- 1 caixa
Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas se dor ou cólica.
3) Diclofenaco 50mg ----- 10 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 5 dias.
4) Ácido mefenâmico 500mg ----- 1 caixa
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas se cólica intensa.
OU 4) Ácido tranexâmico 250mg ----- 36 comprimidos
Tomar 4 comprimidos, 3 vezes ao dia, por 3 dias.

Gonorreia • CID O98.2

■ - TESTE RÁPIDO PARA HIV - HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc IgM e IgG - Anti-HCV - VDRL e FTA-Abs

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

Genital: [secreção uretral purulenta abundante / corrimento cervical mucopurulento]. Disúria. Avaliar aco-

■ PS / Sala — Prescrição — PS

CEFTRIAXONA 500MG IM DOSE ÚNICA AGORA

■ Casa — Prescrição — Casa

DOXICILINA 100MG -----

TOMAR 01CP DE 12/12HORAS POR 7 DIAS

OU (GESTANTE)

CEFTRIAXONA 500MG IM DOSE ÚNICA AGORA

■ Casa — Prescrição — Casa

AZITROMICINA 500MG -----

TOMAR 02 CP, DOSE ÚNICA

EVITAR ROUPAS JUSTAS E DE MATERIAL SINTÉTICO (EX: CALCINHA DE RENDA)

NÃO UTILIZAR PERFUMES DE VULVA

EVITE DUCHAS VAGINAIS

NÃO UTILIZE SABONETES COMUNS PARA LAVAR A REGIÃO GENITAL, OPTE POR SABONETES ÍNTIMOS

ACOSTUME-SE A DORMIR SEM CALCINHA

Herpes Genital • CID A60 · A60.9

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

Genital: vesículas agrupadas e/ou úlceras rasas DOLOROSAS em base eritematosa, [adenopatia inguinal dolorosa]

■ Casa — Prescrição — Casa

1- ACICLOVIR 200 MG _____ 50 COMPRIMIDOS

TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 4/4H, EXCETUANDO-SE UMA DOSE NOTURNA, POR 10 DIAS

HORÁRIO SUGERIDO: 06:00 / 10:00 / 14:00 / 18:00 / 22:00

■ Casa — Profilaxia (indicada se > 6 episódios/ano)

1- ACICLOVIR 200 MG _____

TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H

■ Casa — Prescrição — Casa

ACICLOVIR 400MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 5-7 DIAS

DIPIRONA 1G

TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE

Incontinência Urinária • CID R32

■ tratar constipação/DPOC/ICC/DM, evitar cafeína e bebidas alcoólicas, fazer fisioterapia pélvica

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Avaliar tipo (esforço/urgência/mista): teste de esforço, [prolapso genital], resíduo pós-miccional. Toque:

■ Casa — Prescrição — Casa

OXIBUTININA 5MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS

OU IMIPRAMINA 10MG

TOMAR 01 CP AO DIA

Linfogranuloma Venéreo · CID A55

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Genital: úlcera/pápula transitória (pode passar despercebida) seguida de adenopatia inguinal dolorosa (bubã)

■ Casa — Prescrição — Casa

DOXICICLINA 100MG ----- 42 CPS
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 21 DIAS

Mastite

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril., [febril].
SSVV: PA __/__ | FC __ | FR __ | SatO2 __% | Tax __°C.
Mama [D/E]: área de eritema, calor, dor e endurecimento (geralmente lactante). Avaliar flutuação (abscesso)

■ Casa — Prescrição — Casa

CEFALEXINA 500MG
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, POR 10 A 14 DIAS
OU AMOXICILINA 500MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 10 A 14 DIAS

Nefrolitíase / Cólica Nefrética · CID N23

■ tansulosina para cálculos <1 cm SEM infecção
HEMOGRAMA, UREIA, CREATININA, URINA I, TC SEM CONTRASTE DE ABDOME

Exame físico

[REG por dor], inquieto, sem posição antálgica.
SSVV: PA __/__ | FC __ | FR __ | SatO2 __% | Tax __°C.
Giordano [positivo à D/E]. Abdome flácido, dor em flanco/fossa lombar, sem irritação peritoneal. [Sem febre]

■ PS / Sala — AGORA

DIETA ZERO
SF 0,9% 500ML EV
BUSCOPAN COMPOSTO EV
CETOPROFENO EV

■ PS / Sala — Sem melhora

TRAMADOL 100MG + SF 0,9% 100ML EV LENTO
BROMOPRIDA 10MG EV
Encaminhar Urologista
Internação: febre, rim único, função renal limítrofe, gestante, imunossuprimidos

■ Casa — Prescrição — Casa

BUSCOPAN COMPOSTO -----
TOMAR 01 CP DE 6/6H, SE DOR
CETOPROFENO 100MG -----
TOMAR 01 CP DE 12/12H POR 5 DIAS
BROMOPRIDA 10MG -----
TOMAR 01 CP 8/8H, SE NAUSEA OU VOMITO
TANSULOSINA 0,4MG -----
TOMAR 01 CP 1X AO DIA POR 4-6 SEMANAS

Orquiepididimite · CID N45

■ suspensório escrotal (melhora a dor) por 10 dias, evitar esforço físico, encaminhar urologista

ENDOCRINOLOGIA

Idoso

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., [febril].
SSVV: PA __/__ | FC __ | FR __ | SatO2 __% | Tax __°C.
Bolsa escrotal [D/E]: dor e edema de epidídimo/testículo, [hiperemia], Prehn positivo (alívio com elevação)

■ PS / Sala — Jovem

AGORA: CEFTRIAXONA (250MG/2ML) 1 AMP EV

■ Casa — Prescrição — Casa

DOXICICLINA 100MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 10 DIAS
DIPIRONA 500MG
TOMAR 01 A 02 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR
IBUPROFENO 600MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 3 DIAS

■ Casa — Prescrição — Casa

LEVOFLOXACINO 500MG
TOMAR 01 CP DE 24/24 HORAS POR 10 DIAS
DIPIRONA 500MG
TOMAR 01 A 02 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR

IBUPROFENO 600MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 3 DIAS

Pielonefrite · CID N11

■ retornar em 48-72h para reavaliação
Ambulatorial

Exame físico

REG/BEG, [febril].
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Giordano POSITIVO à [D/E]. Abdome sem sinais de irritação peritoneal. Avaliar toxemia/instabilidade (indica

■ PS / Sala — Prescrição — PS

SF 250ML + 1 AMP DIPIRONA
HEMOGRAMA, UREIA, CREATININA, URINA I, UROCULTURA, ANTIBIOGRAMA, Na, K – SE DISPONIVEL USG VIAS
URINARIAS E HEMOCULTURA
Exames Laboratoriais: a urina tipo I demonstra pH tendendo a alcalino, leucocitúria e hematúria

■ Casa — Prescrição — Casa

LEVOFLOXACINO 750MG
TOMAR 01 CP AO DIA POR 7 DIAS
OU CIPROFLOXACINO 500 mg
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS
DIPIRONA 500MG
TOMAR 01 A 02 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR
BROMOPRIDA 10MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, SE NAUSEA OU VOMITO
Internação (sepse, complicação, comorbidade significativa, não aceitação oral, não controle dos sintomas, g
SF 30-40ML/KG EM 24H
DIPIRONA 1G 6/6 HORAS, SE DOR
BROMOPRIDA 10MG EV 8/8 HORAS, SE NAUSEA OU VOMITO
CIPROFLOXACINO 400MG EV 12/12 HORAS
OU CEFTRIAXONA 2G EV 24/24H

Sangramento Uterino Anormal · CID N93

■ Sangramento crônico

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril., [palidez se sangramento importante].
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C. (avaliar repercussão/hipotensão).
Especular: origem do sangramento, volume, [coágulos]. βhCG. Avaliar anemia sintomática.

■ PS / Sala — Sangramento agudo

DIETA BRANDA
RINGER LACTATO 500- 2000L EV CORRER RAPIDO
MONITORIZAÇÃO
GLICEMIA CAPILAR
GLICOSE HIPERTONICA 50% 20ML EV SE HGT <70
RESPOUSO NO LEITO
ÁCIDO TRANEXÂMICO 10mg/kg EV (Dose máxima 600mg/dose) AGORA
OU

■ Casa — Prescrição — Casa

ÁCIDO TRANEXAMICO 1,5G VO DE 8/8 HORAS POR 5 DIAS

■ Casa — Prescrição — Casa

LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15MG/0,03 MG
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS. DEPOIS, 1 CP POR DIA POR 21 DIAS
OU INSERIR DIU LEVONORGESTRAL
OU IBUPROFENO 600MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 5 DIAS
OU DICLOFENACO 50MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 5 DIAS
OU ACIDO MEFENAMICO 500MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 4 DIAS
OU ACIDO TRANEXAMICO 500MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 4 DIAS

Sífilis · CID A51 · A53.9

■ - TESTE RÁPIDO PARA HIV - HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBc IgM e IgG - Anti-HCV

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Primária: cancro DURO – úlcera única, indolor, base endurecida, adenopatia indolor. Secundária: roséola/les

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Rx USO INTRAMUSCULAR
1- PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI ___ 02 AMPOLAS

APLICAR UMA AMPOLA EM CADA GLÚTEO MÉDIO
OU
1- PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI ____ 06 AMPOLAS
APLICAR UMA AMPOLA EM CADA GLÚTEO MÉDIO, A CADA 07 DIAS, ATÉ
COMPLETAR TRÊS DOSES

■ Casa — Recente

PENICILINA G BENZATINA 2,4 MILHOES -----
APLICAR 1,2 MILHAO IM EM CADA GLUTEO, DOSE ÚNICA
OU DOXACILINA 100MG -----
TOMAR 01 CP DE 12/12HORAS POR 15 DIAS

■ Casa — Tardia

PENICILINA G BENZATINA 2,4 MILHOES -----
APLICAR 1,2 MILHAO IM EM CADA GLUTEO 1X/ SEMANA, POR 3 SEMANAS
OU DOXACILINA 100MG -----
TOMAR 01 CP DE 12/12HORAS POR 30 DIAS

Tricomoniase · CID A59

■ não beber álcool _____

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.
Especlar: corrimento amarelo-esverdeado bolhoso, abundante, colo 'em framboesa', pH >4,5, prurido/ardor vu

■ Casa — Rx USO ORAL

1- METRONIDAZOL 250 MG _____ 28 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 12/12h POR 07 DIAS
OU USO INTRAVAGINAL
2- METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100mg/g _____ 01 BISNAGA
APLICAR O CONTEÚDO DE UM APLICADOR CHEIO DENTRO DA VAGINA, À
NOITE AO DEITAR, POR 07 NOITES
EVITAR ROUPAS JUSTAS E DE MATERIAL SINTÉTICO (EX: CALCINHA DE
RENDA)
NÃO UTILIZAR PERFUMES DE VULVA
ACOSTUME-SE A DORMIR SEM CALCINHA

■ Casa — Prescrição — Casa

METRONIDAZOL 400MG -----
TOMAR 05 CPS, DOSE ÚNICA
OU METRONIDAZOL 250MG -----
TOMAR 02 CPS DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS

Vaginose · CID N76 · N76.1

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.
Especlar: corrimento branco-acinzentado homogêneo, aderente, odor de peixe (teste de aminas +), pH >4,5, S

■ Casa — Prescrição — Casa

1- METRONIDAZOL 250 MG _____ 28 COMPRIMIDOS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 12/12h POR 07 DIAS
EVITAR ROUPAS JUSTAS E DE MATERIAL SINTÉTICO (EX: CALCINHA DE
RENDA)
NÃO UTILIZAR PERFUMES DE VULVA
EVITE DUCHAS VAGINAIS
ACOSTUME-SE A DORMIR SEM CALCINHA
NÃO UTILIZE SABONETES COMUNS PARA LAVAR A REGIÃO GENITAL, OPTE
POR SABONETES ÍNTIMOS

■ Casa — Prescrição — Casa

METRONIDAZOL 250MG -----
TOMAR 02 CPS DE 12/12HORAS POR 7 DIAS
OU

■ Casa — Prescrição — Casa

METRONIDAZOL GINECOLÓGICO 100MG/G -----
1 APLICADOR INTRAVAGINAL POR 5 NOITES

■ Pele

Abscesso Cutâneo · CID L02

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA ____/____ | FC ____ | FR ____ | SatO2 ____% | Tax ____°C.
Pele: coleção flutuante, eritematosa, dolorosa em [localização], [com/sem] celulite perilesional. [Sem sina

■ Casa — Prescrição — Casa

CEFALEXINA 500MG -----
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS POR 7 DIAS
DIPIRONA 500MG -----
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS SE DOR
IBUPROFENO 600MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, POR 5 DIAS
COMPRESSA QUENTE POR 20 MINUTOS 2X AO DIA POR 5 DIAS

Alergia · CID T78.4

■ LOCALIZADA
EXTENSA

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Pele: lesões [urticariiformes/eczematosas] em [localização], [com/sem] sinais de infecção secundária. Sem ed

■ PS / Sala — Prescrição — PS

IM: FENERGAN

■ Casa — Prescrição — Casa

CETOPROFENO 100MG -----
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 5 DIAS

■ Casa — Prescrição — Casa

DEXAMETASONA CREME 1MG/G -----
APLICAR EM LESÕES 2X AO DIA POR 10-14 DIAS
OU MOMETASONA 1MG/G -----
APLICAR FINA CAMADA EM LESÕES 1X AO DIA

■ Casa — Prescrição — Casa

HIDROXIZINA 25MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8H POR 3 DIAS
OU DESLORATADINA 5MG -----
TOMAR 01CP 1X AO DIA POR 5 DIAS

■ Casa — Prescrição — Casa

PREDNISONA 20MG-----
TOMAR 01 CP DE 12/12H POR 5-14 DIAS
HIDROXIZINA 25MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8H

Dermatite de Contato · CID L24.9

■ Quadro localizado
DEXAMETASOMA 0,1% CREME APLICAR NAS LESÕES 2X AO DIA POR 10-14 DIAS OU
Quadro extenso

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Pele: eritema, vesículas, [descamação/liquenificação se crônica] com distribuição na área de contato (padrã

■ Casa — Para face e áreas de dobra

HIDROCORTISONA 1% CREME
APLICAR NAS LESÕES 2X AO DIA POR 10-14 DIAS
E/OU
HIDROXIZINA 25MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, SE PRURIDO
OU DEXCLORFENIRAMINA 2MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, SE PRURIDO

■ Casa — Prescrição — Casa

PREDNISONA 20MG
TOMAR 0,5mg/kg/dia POR 5-14 DIAS
HIDROXIZINA 25MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, SE PRURIDO
OU DEXCLORFENIRAMINA 2MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, SE PRURIDO

Dermatite Perioral · CID L71.0

■ HIDROCORTISONA 1% CREME APLICAR NAS LESÕES 1-2X AO DIA POR 5-7 DIAS
E METRONIDAZOL 0,75% GEL APLICAR NAS LESÕES 2X POR DIA TÊ MELHORA CLÍNICA OU CLINDAMICINA 1% GEL OU LOÇÃO
(manipulado) APLICAR NAS LESÕES 1-2X POR DIA ATÉ MELHORA CLÍNICA

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Face: pápulas e pústulas eritematosas perorais, poupando a borda vermelha dos lábios (zona clara). História

■ Casa — Casos extensos/ não responsivos

TETRACICLINA 250MG
TOMAR 02 CPS 2X AO DIA POR 8-12 SEMANAS

OU DOXACICLINA 100MG
TOMAR 01 CP 1-2X POR DIA POR 8-12 SEMANAS

Drenagem Abscesso

■ Prescrito analgésico para controle da dor.

Não manipular a lesão Evitar calçados fechados/apertados Manter local limpo e seco

- Separar material - Clorexidina alcoólico - Campo operatório - Anestesia local: agulha marrom ou preta (+ finas) - Incisão pequena com lamina 11 (+ pontiaguda) + Kelly para ajudar (ampliar), se necessario - Drenagem - Colocar gaze dentro da loja, se não houver drenagem espontânea - Curativo: gaze + micropore

DURAÇÃO

DATA DE INÍCIO

1) SABONETE ANTISSEPTICO PASSAR EM REGIÕES AFETADAS NO BANHO, POR 10 DIAS. 2) Mupirocina creme Passar fina camada nas lesões, 2 a 3 vezes por dia, por 10 dias.

Bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril Sem edema, hiperemia ou alterações visíveis Cavidade oral sem secreção purulenta evidente.

Meta: redução GRADUAL em 24–48h. NÃO forçar queda rápida.

NÃO usar Nifedipino sublingual (queda abrupta = isquemia tecidual).

DE ALTA: - Retornar ao ambulatório/UBS em ATÉ 7 DIAS para reavaliação e ajuste do esquema - Manter e/ou iniciar anti-hipertensivo de base conforme abaixo - Aumentar ingesta hídrica - Dieta hipossódica - Retornar IMEDIATAMENTE se: déficit neurológico, dor no peito, falta de ar, alteração visual, piora da cefaleia

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., [afebril].

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Coleção flutuante, eritematosa e dolorosa em [local], [ponto de drenagem]. Avaliar celulite perilesional e

■ PS / Sala — Prescrição Ceftriaxona

FAZER CEFTRIAXONA 2G + 100 ML SF 0,9% EV 1X AO DIA - CORRER EM 30 MINUTOS

■ PS / Sala — Prescrição — PS

CID: I16.1

→ INTERNAR EM UTI

→ Anti-hipertensivo EV + monitorização contínua

→ Reduzir no máx. 25% da PAM na 1ª hora, depois gradual em 24-48h

(exceção: dissecação de aorta – redução mais agressiva)

■ PS / Sala — Nitroprussiato de sódio EV — EAP, encefalopatia, crise adrenérgica

Nitroglicerina EV – SCA, IAM, IC descompensada

Labetalol ou Nicardipino EV – AVC hemorrágico (meta PAS < 140)

Nitroprussiato + Esmolol EV – Dissecação de aorta (meta PAS < 120 em 20 min)

Hidralazina EV + Sulfato de Magnésio – Eclâmpsia / pré-eclâmpsia grave

■ PS / Sala — Prescrição — PS

Fentolamina EV – Crise de feocromocitoma

■ Casa — Se DM ou NPO

DEXTRO

INSULINA REGULAR 100UI CONFORME DEXTRO

GLICOSE 50%, SE HIPOGLICEMIA

FOLICULITE L73.9

■ Casa — Prescrição — Casa

3) DIPIRONA 500MG -----

TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR

CID K088 DOR DE DENTE

PACIENTE REFERE DOR DE DENTE HÁ 1 DIA. Nega febre ou outros sintomas sistêmicos. INFORMO QUE NÃO TEM DENTI

#MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO: NEGA

#COMORBIDADES PRÉVIAS: NEGA

#ALERGIAS: NEGA ALERGIAS MEDICAMENTOSAS CONHECIDAS.

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Dipirona 500mg ----- 20 comprimidos

Tomar via oral 2 comprimidos de 6 em 6 horas se dor ou febre.

2) Diclofenaco 50mg ----- 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas por 5 dias.

Orientado que a unidade não dispõe de atendimento odontológico, sendo necessária continuidade do acompanham

Orientado procurar serviço de urgência odontológica (ex: UPA com suporte odontológico) em caso de piora do

Sem sinais de infecção sistêmica no momento.

Orientado retorno se surgirem sinais de alarme, como febre, edema local, trismo ou piora da dor.

Onicocriptose / UNHA ENCRAVADA L60.0

■ Casa — Prescrição — Casa

1) CEFALEXINA 500MG -----

TOMAR 01 CP VO DE 6/6 HORAS POR 7 DIAS

2) DIPIRONA 500MG -----

TOMAR 01 A 02 CP VO DE 6/6 HORAS SE DOR

3) IBUPROFENO 300MG -----

TOMAR 02 CP VO DE 8/8 HORAS, POR 5 DIAS

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Captopril 25mg ----- 2 comprimidos

Tomar 1 comprimido agora. Repetir em 60 min se PA ainda ≥ 180/110 mmHg.

ou
1) Clonidina 0,1mg ----- 2 comprimidos
Tomar 1 comprimido agora. Repetir em 60 min se necessário.
(Preferir em casos de ansiedade/hiperatividade simpática. Atenção: risco de rebote se uso crônico suspenso)
2) Dipirona 1g (500mg/comp) ----- 4 comprimidos
Tomar 2 comprimidos VO agora se cefaleia ou dor.
ou
Dipirona 500mg/ml solução oral
Tomar 40 gotas VO agora se cefaleia ou dor.

■ Casa — Prescrição — Casa

OPÇÃO 1 — IECA
Enalapril 10mg ----- 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas.
Enalapril 20mg ----- 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 12 em 12 horas.
ou
Captopril 25mg ----- 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas.
OPÇÃO 2 — BRA
Losartana 50mg ----- 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido, 1x ao dia.
Losartana 100mg ----- 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido, 1x ao dia.
OPÇÃO 3 — BCC
Anlodipino 5mg ----- 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido, 1x ao dia.
Anlodipino 10mg ----- 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido, 1x ao dia.
OPÇÃO 4 — DIURÉTICO
Hidroclorotiazida 25mg ----- 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido pela manhã.
Clortalidona 25mg ----- 30 comprimidos
Tomar 1 comprimido pela manhã.

■ Internação — INTERNAÇÃO

DIETA
SF 0,9 500ML EV, ACM
SORO GLICOFISIO 500ML EV, ACM
DIPIRONA 1G 6/6H, SE DOR OU FEBRE
TRAMAL 100MG 6/6H, A CRITÉRIO MÉDICO
METOCLOPRAMIDA 8/8H, SE NAUSEA OU VÔMITO
OMEPRAZOL 40MG VO/EV 1X AO DIA
LACTULOSE 667MG/ML 10ML DE 12/12H, SE CONSTIPAÇÃO
ENOXAPARINA 40MG/G SC 24/24H
MEDICAÇÕES DE USO CONTÍNUO
EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM
Se quadro infeccioso: UROCULTURA E HEMOCULTURA.
CONTROLE DOS SINAIS VITAIS 6/6H
CABECEIRA ELEVADA 30°
DEAMBULAÇÃO / REPOUSO RELATIVO NO LEITO / REPOUSO NO LEITO

Erisipela / Celulite · CID A46 · L03

■ Ambulatorial (erisipela localizado, sintomas sistêmicos ausentes/leves):

- Compressa gelada 3x ao dia por 15 minutos

Se presença de bolhas

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., [febril].

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Pele [membro/face]: placa eritematosa, quente, dolorosa, [bordas nítidas na erisipela / difusas na celulite]

■ Casa — Prescrição — Casa

AMOXICILINA + CLAVULANATO 875/125MG -----
TOMAR 01 DE 12/12 HORAS POR 10 DIAS
OU CEFALEXINA 500MG -----
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS POR 7 DIAS
Se > 70kg: 1g de 6/6 horas
DIPIRONA 500MG -----
TOMAR 01 A 02 CPS DE 6/ HORAS, SE DOR
BROMOPRIDA 10MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, SE NAUSEA OU VÔMITO
OMEPRAZOL 20MG -----
TOMAR 01 CP 1X AO DIA, PELA MANHÃ

■ Casa — Prescrição — Casa

NEOMICINA + BACITRACINA 20G
APLICAR SOBRE LESÃO 2X AO DIA

■ Casa — Se não melhorar só com cefalexina, associar

CEFALEXINA 500MG ----- 28 CPS
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS POR 7 DIAS
CLINDAMICINA 300MG -----
TOMAR 01 CP DE 6/6H OU 8/8H POR 7 DIAS

■ Internação — Internação

CEFAZOLINA 1G EV DE 8/8 HORAS POR 7-14 DIAS
OU CEFTRIAXONA 1G EV DE 12/12 HORAS POR 7-14 DIAS
OU CLINDAMICINA 600MG EV DE 8/8 HORAS, POR 7-14 DIAS
DIPIRONA 1G EV DE 6/6 HORAS, SE DOR
BROMOPRIDA 10MG EV DE 8/8HORAS, SE NAUSEA OU VOMITO

Escabiose • CID B86 · B68

■ Trocar a roupa de cama, de banho e a do corpo (que foi usada no dia do tratamento e nos dias anteriores, inclusive). Fazer isso diariamente por, pelo menos, três dias. Lavar as roupas, estender e deixá-las expostas ao sol quente, complementando com ferro de passar, para eliminar o parasita. Caso a lavagem das roupas não seja possível, é recomendado fechá-las em saco plástico por quatro a sete dias. Manter as unhas curtas. tratar todos do mesmo domicílio, trocar roupa de cama 1x ao dia por 3 dias, estender roupas no sol, manter unhas curtas

PERMETRINA 5% LOÇÃO/CREME APLICAR 1-3 NOITES SEGUIDAS. REPETIR EM 7 DIAS

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Pele: pápulas e escoriações pruriginosas em espaços interdigitais, punhos, axilas, cintura, região genital.

■ Casa — Prescrição — Casa

1) Ivermectina 6 mg (1 CP) PRECISA FAZER A CONTA POR QUILO -----
Tomar 200 microgramas/kg/dia VO dose única. Repetir a dose em 7 dias.
+
2) Permetrina 5% loção ou creme ----- 1 frasco
Aplicar no corpo todo (em adultos, poupar a região cefálica; em crianças e na sarna crostosa incluir couro
OU 2) Enxofre precipitado 5% (manipular em vaselina) ----- 1 frasco
Aplicar no corpo todo (poupar região cefálica) por 3-4 noites seguidas.
3) Loratadina 10 mg ----- 7 comprimidos
Tomar 1 comprimido, uma vez ao dia, por até 7 dias.
OU 3) Hidroxizina 25mg ----- 7 comprimidos
Tomar 1 comprimido à noite por 7 noites.

■ Casa — Prescrição — Casa

IVERMECTINA 6MG (200MCG/KG/DIA)
TOMAR 1CP VO, DOSE ÚNICA. REPETIR EM 7 DIAS.
LORATADINA 10MG
TOMAR 01 CP 1X AO DIA POR 5 DIAS

Furunculo / Carbunculo • CID L02

■ ACIDO FUSIDICO 2% CREME ----- APLICAR NA LESÃO 2X AO DIA POR 7 DIAS OU ATE MELHORA CLÍNICA COMPRESSA QUENTE POR 20 MINUTOS 2X AO DIA POR 5 DIAS LAVAR LOCAL COM SABÃO DE CLOREXIDINA OU MUPIROCINA 2% POMADA ----- APLICAR NA LESÃO 2X AO DIA POR 7 DIAS OU ATE MELHORA CLÍNICA COMPRESSA QUENTE POR 20 MINUTOS 2X AO DIA POR 5 DIAS LAVAR LOCAL COM SABÃO DE CLOREXIDINA OU COMPRESSA QUENTE POR 20 MINUTOS 2X AO DIA POR 5 DIAS LAVAR LOCAL COM SABÃO DE CLOREXIDINA
Se furúnculo de repetição
MUPIROCINA 2% POMADA PASSAR 2X AO DIA NAS NARINAS POR 5-10 DIAS ANTISSEPTICO (CLOREXIDINA DEGERMANTE OU TRICLOSAN SABONETE) LAVAR GENITALIA, AXILAS, REGIÃO INGUINAL E INFRAMAMÁRIA POR 7 DIAS

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Pele: nódulo(s) foliculares eritematosos e dolorosos com [ponto de pus central], carbúnculo = confluência d

■ Casa — Prescrição — Casa

CEFALEXINA 500MG -----
TOMAR 01 CP DE 6/6HORAS POR 7-14 DIAS

Herpes Simples • CID B00.9

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Pele/mucosa: vesículas agrupadas em base eritematosa em [lábio/genital], [± úlceras rasas dolorosas]. Sem s

■ Casa — Prescrição — Casa

ACICLOVIR 400MG -----
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS POR 5 DIAS OU POR 7 DIAS (primoinfecção)
DIPIRONA 500MG -----
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE

Herpes Zoster · CID B02

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Pele: vesículas agrupadas sobre base eritematosa, distribuição em dermatomo [___], unilateral, sem ultrapassar

■ Casa — Prescrição — Casa

ACICLOVIR 400MG
TOMAR 02 CPS 5X AO DIA POR 7-10 DIAS
DICLOFENACO 50MG
TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS
OU PARACETAMOL + CODEINA 500+7,5MG
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR INTENSA

Hidradenite Supurativa · CID L73.2

■ CLINDAMICINA GEL 1% APLICAR NA LESÃO DE 12/12 HORAS ATÉ MELHORA CLÍNICA OU ÁCIDO FUSÍDICO CREME 2% APLICAR NA LESÃO DE 8/8 HORAS ATÉ MELHORA CLÍNICA Encaminhar Dermatologista

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Áreas intertriginosas (axila/inguinal/inframamária): nódulos dolorosos recidivantes, abscessos, [fístulas,

■ Casa — Prescrição — Casa

DIPIRONA 500MG
TOMAR 01 A 02 CPS DE 6/6 HORAS, SE DOR OU FEBRE

Impetigo · CID L01

■ lavagem com água + sabão ou sabonete antissépticos (triclosan, clorexidina)

MUIPIROCINA 2% CREME APLICAR DE 8/8 HORAS POR 5-7 DIAS
Se quadro extenso, sintomas sistêmicos, falha tratamento tópico

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., afebril.
Pele: lesões com crostas melicéricas [± bolhas] em [face/membros], sem celulite/abscesso associado. Sem sin

■ Casa — Prescrição — Casa

CEFALEXINA 500MG
TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS POR 7 DIAS
OU SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 800 + 160MG/CP
TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 7-10 DIAS

Pediculose · CID B85.1

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Couro cabeludo (ou púbis): lêndeas aderidas à haste do cabelo, [piolhos vivos], escoriações por prurido, [a

■ Casa — Prescrição — Casa

PERMETRINA 1% SHAMPOO
APLICAR NO COURO CABELUDO, DEIXAR AGIR POR 10 MINUTOS E ENXAGUAR. REPETIR 3-5 VEZES POR SEMANA
OU PERMETRINA 5% LOÇÃO
APLICAR NO COURO CABELUDO A NOITE E LAVAR O CABELO NO DIA SEGUINTE. APLICAR POR 3 NOITES SEGUIDAS E
REPETIR O TRATAMENTO APÓS 7 DIAS
E
ÁCIDO ACÉTICO 5%
APLICAR 10ML DE ÁCIDO ACÉTICO + 10ML DE ÁGUA FRIA ANTES DE PASSAR O PENTE FINO
E/OU

■ Casa — Prescrição — Casa

IVERMECTINA 6MG
TOMAR 200 MCG/KG, DOSE ÚNICA. REPETIR APÓS 7 DIAS.

Queimadura · CID T30.0

■ LAVAR COM AGUA CORRENTE ABUNDANTE, RETIRAR TODOS OS OBJETOS/ROUPAS. RETIRAR CORPOS ESTRANHOS, LIMPEZA COM AGUA E CLOREXIDINA DEGERMANTE, CURATIVO OCLUSIVO
SULFADIAZINA DE PRATA 1% (DERMAZINE/PRATAZINE) PASSAR EM LESÃO 1X AO DIA LIMPEZA DA FERIDA (SORO FISIOLÓGICO OU CLOREXEDINE DERGEMANTE) MEMBRACEL CURATIVO APÓS HIGIENIZAÇÃO, APLICAR CURATIVO E APÓS, COBRIR LOCAL COM GAZE E FAIXA, FIXE COM ESPARADRAPO OU FITA ADESIVA

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Queimadura em [local]: profundidade [1º/2º superficial/2º profundo/3º], SCQ estimada ___% (regra dos 9). Ava

■ PS / Sala — Queimadura 3º grau

DIETA ZERO, ATÉ ESTABILIZAÇÃO
RINGER LACTATO AQUECIDO (4 x PESO x SCQ) – METADE DO VOLUME EM 8 HORAS E A OUTRA METADE NAS

PRÓXIMAS 16 HORAS

TRAMADOL 100MG + SF 0,9% 100ML + BROMOPRIDA 10MG

OU MORFINA 10MG/ML + SG% 9ML - FAZER 3ML EV

SONDA VESICAL - manter debito em 0,5 ml/kg/hora

Internar: queimadura 2º grau >10%, queimadura em face/mãos/pés/genitálias, queimadura 3º grau, queimadura v
aérea, queimadura elétrica

■ Casa — Prescrição — Casa

DIPIRONA 500MG

TOMAR 01 A 02 CPS DE 6/6 HORAS, SE DOR

OU PARACETAMOL + CODEÍNA 500MG + 7,5MG

TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS, SE DOR

HIDROXIZINA 25MG

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS, SE COCEIRA

Queimadura Elétrica · CID W87.9

■ ECG, hemograma, uréia, creatinina, troponina, CPKM, CPK, Urina I

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

SSV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Marcas de entrada/saída da corrente em [locais]. Lesão tecidual pode ser MUITO maior que a aparente. ECG/mo

■ PS / Sala — Prescrição — PS

ABCDE

RINGER LACTATO

4x SQ x peso - CORRER 50% NAS PRIMEIRAS 8 HORAS

DIPIRONA 1G EV 6/6 HORAS, SN

TRAMAL 100MG 6/6 HORAS, SN

MONITORIZAÇÃO CONTINUA 12-24HORAS

SVD - QUANTIFICAR DIURESE

REMÉDIOS

■ Casa — Expectorante

AMBROXOL XAROPE SEM AÇUCAR

TOMAR 5ML 3X AO DIA POR 5 DIAS

ACETILCISTEINA 600MG

TOMAR 1X A NOITE POR 5 NOITES

ACETILCISTEINA XAROPE 40mg/ml

TOMAR 15ML A NOITE POR 5 NOITES

ACETILCISTEINA ENVELOPE 600mg/5g

TOMAR 1 ENVELOPE A NOITE POR 5 NOITES

VICK 44E XAROPE

TOMAR 15 ML DE 6/6 HORAS

■ Casa — Tosse seca

SEKI XAROPE

TOMAR 10 ML 3X AO DIA POR 5 DIAS

OU CLOPERASTINA 3,54MG/ML

TOMAR 10ML 3X AO DIA POR 5 DIAS

■ Casa — Antitussígeno

DROPROPIZINA 3MG/ML

TOMAR 10ML 4X AO DIA

■ Casa — Dor de garganta

STREPSILS/FLOGORAL PASTILHA

1 PASTILHA, SEMPRE QUE NECESSÁRIO

CLORIDRATO DE BENZIDAMINA PASTILHA

01 PASTILHA VO DE ATÉ 3/3 HORAS, SE DOR DE GARGANTA

■ Casa — Resfriado

CORISTINA D, CIMEGRIPE, RESFENOL (paracetamol, clorfeniramina, fenilefrina)

TOMAR 01 CP DE 6/6 HORAS

NEOLEFRIN (fenilefrina, carbinoxamina, paracetamol)

TOMAR 01 CP DE 8/8 HORAS

BENEGRIPE (dipirona, clorfeniramina, cafeína)

TOMAR 3X AO DIA

DECONGEX PLUS

TOMAR 10 A 15ML 3X AO DIA

■ Casa — Anti-inflamatório + protetor gástrico

NIVUX

TOMAR 01 CP DE 12/12 HORAS POR 3 DIAS

Pomada

TROK-N

APLICAR FINA CAMADA SOBRE LESÃO 1-2X POR DIA, POR 7-10 DIAS

EXAMES

■ Casa — ISTs

HBsAg, Anti-HCV, anti HIV 1 e 2, anti-HAC total, Anti HBs, anticorpos anti-gonococo IgM e IgG, chlamydia tr

IgM e IgG, VDRL.

Rotina

Hemograma, uréia, creatinina, sódio, potássio, TGO, TGP, glicemia de jejum, triglicérides, colesterol total

25-hidroxivitamina D, vitamina B12, TSH, T4 livre, ferritina.

Em > 50 anos: sangue oculto nas fezes e mamografia

Em mulheres > 65 anos/ homens > 70 anos/ fatores de risco: densitometria óssea.

Em DM: Hb glicada

PROCEDIMENTOS

Tínea Capitis

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.

Couro cabeludo: placa(s) de alopecia com descamação, [cabelos tonsurados, pontos pretos], [querion = placa

■ Casa — Prescrição — Casa

GRISEOFULVINA (manipulado)

TOMAR 500MG 1X AO DIA OU DE 12/12 HORAS, DURANTE A REFEIÇÃO, POR 5-7 DIAS

■ Psiquiatria

Abstinência Alcoólica · CID F10.3

Exame físico

[Ansioso/agitado, tremor].

SSV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Tremor de extremidades, sudorese, taquicardia, HAS. Avaliar gravidade (CIWA-Ar): alucinações, convulsão, de

■ PS / Sala — Prescrição — PS

HEMOGRAMA, GLICEMIA, UREIA, CREATININA, TGO, TGP, AMILASE, LIPASE

DIAZEPAM 10MG

01 CP A CADA HORA, ATÉ MELHORA (máximo: 40mg/dia)

OU LORAZEPAM 2MG

01 CP A CADA HORA, ATÉ MELHORA (máximo: 10mg/dia)

E

TIAMINA 100- 250MG EV/IM 1X/ DIA POR 3 DIAS

■ PS / Sala — Se hipoglicemia (fazer tiamina antes)

GLICOSE HIPERTÔNICA 50%: 4 AMP EV

■ PS / Sala — Se Delirium tremens

DIAZEPAM 5-10MG EV, A CADA 5-10 MINUTOS (Maximo: 20mg/dia)

■ PS / Sala — Se refratário

FENOBARBITAL 130-260MG EV A CADA 15 MIN ATÉ MELHORA (máximo: 15 mg/kg/dia)

PACIENTE GRAVE

■ Gestante

Anemia (gestante) · CID O99.0

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.

SSV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Palidez cutâneo-mucosa. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___ cm | tônus uterino normal | dinâmica ausente | sem p

Hb ___ (ajustar meta na gestação).

■ Casa — Prescrição — Casa

Profilaxia: Sulfato ferroso 40mg + Ácido fólico 0,2mg/mL 60 gotas – até o 3º mês de puerpério.

Tratamento: ajustar sulfato ferroso conforme hemoglobina.

Ansiedade / Depressão (gestante) · CID F41

■ Insônia: Neozine 40mg/ml 5 gotas VO à noite.

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.

SSV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Humor/afeto [___], ansiedade, [insônia]. Avaliar risco (ideação, funcionalidade). Obstétrico: BCF ___ bpm | A

■ PS / Sala — Crise de ansiedade

Neozine 40mg/ml – 5 gotas VO.

Prometazina – 1 amp IM.

Diazepam 5mg – 1 cp VO se na maternidade e refratária a outras medidas.

■ Casa — Manutenção

Sertralina 50mg – 1 cp VO 1x ao dia.

Broncoespasmo / Crise asmática (gestante) · CID J45

■ Crises graves: considerar corticoide, porém avaliar se é PNAR e vai precisar de doppler — o corticoide anula a avaliação do ducto venoso.

Exame físico

[REG], [taquipneica].
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
AP: sibilos difusos, SatO2 ___% (manter ≥95% – feto é sensível à hipóxia). Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___ cm

- Casa — Prescrição — Casa
Salbutamol (spray/nebulização).

Candidíase (gestante) · CID B37

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.
Especular: corrimento branco grumoso aderido, prurido/hiperemia vulvovaginal, pH normal. Obstétrico: BCF ___

- Casa — Prescrição — Casa
Miconazol creme vaginal – 1 tubete por noite, por 7 noites.
Se candidíase de repetição/importante: Fluconazol 150mg VO dose única.

Clamídia / Gonorreia (gestante) · CID A54 · A56

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.
Especular: colo friável com secreção mucopurulenta. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___ cm | tônus uterino normal
Rastrear/tratar parceria; risco de transmissão perinatal.

- Casa — Prescrição — Casa
Azitromicina 500mg – 2 cp VO dose única
+ Ceftriaxona 250mg IM dose única.

Constipação (gestante) · CID K59.0

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.
Abdome gravídico, RHA+, [distensão leve], indolor. Toque retal se necessário. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___

- Casa — Prescrição — Casa
Óleo mineral.
Lactulona – 10ml VO.
Tamarine – 1 cp VO à noite por 7 dias.
Bisacodil (Dulcolax) 5mg – 1 cp VO.

Diabetes (gestante) · CID O24

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Glicemia capilar ___. Avaliar controle glicêmico. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___ cm | tônus uterino normal |

- Casa — Prescrição — Casa
Insulina (esquema conforme glicemia).

Diarreia (gestante) · CID A09

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril., hidratada.
SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.
Abdome gravídico, RHA+ aumentados, dor difusa leve, sem defesa. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___ cm | tônus u

- Casa — Prescrição — Casa
Soro de reidratação oral.
Floratil 200mg – 1 cp VO de 8/8h por 3 dias.
Enterogermina – 5ml VO de 8/8h por 3 dias.

Doença hemorroidária (gestante) · CID O22.4

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.
Região anal: mamilos hemorroidários [externos/trombosados], sem abscesso/celulite. Obstétrico: BCF ___ bpm |

- Casa — Prescrição — Casa
Diosmina + hesperidina (Proctyl, Daflon) tópico – aplicar na região.

Dor (gestante) · CID R52

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Exame do sítio doloroso [___]. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___ cm | tônus uterino normal | dinâmica ausente |

Evitar AINE (sobretudo 3º trimestre).

■ PS / Sala — Dor intensa (na unidade)

Dipirona 500mg EV se dor intensa.

Decadron 1 amp IM se dor intensa.

Tramal 1 amp EV se dor refratária.

■ Casa — Prescrição — Casa

Paracetamol 500mg VO de 4/4h (pode associar Prednisona 5mg VO de 12/12h se dor intensa).

Miosan 5mg à noite por 3 dias, se cefaleia intensa.

Dor abdominal (gestante) · CID R10

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Abdome gravídico: localizar dor, RHA, defesa/DB. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___ cm | tônus uterino normal |

■ Diferenciar de causas obstétricas (DPP, TPP, pré-eclâmpsia) e cirúrgicas (apendicite).

■ Casa — Prescrição — Casa

Escopolamina (Buscopan) 10mg – 1 cp VO de 8/8h.

OU Escopolamina + paracetamol (Buscoduo) 10+500mg – 1 cp VO de 8/8h.

OU Ranitidina 150mg – 1 cp VO de 8/8h.

Epigastralgia (gestante) · CID K21

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Abdome: dor epigástrica. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___ cm | tônus uterino normal | dinâmica ausente | sem

■ Se 3º trim + HAS/cefaleia/escotomas → afastar pré-eclâmpsia/HELLP (dor em HD/epigástrio).

■ Casa — Prescrição — Casa

Simeco Plus (hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio + simeticona) – 10ml VO de 8/8h.

OU LuftaGastro Pro (alginato de sódio + bicarbonato de potássio) – 10ml VO de 8/8h.

OU Hidróxido de alumínio (Mylanta Plus) – 10ml VO de 8/8h.

Epilepsia (gestante) · CID G40

■ Manter medicação usual, desde que NÃO seja Valproato de Sódio. Aumentar o esquema de ácido fólico no 1º trimestre.

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Pós-ictal se crise recente. Neuro: [déficit?]. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___ cm | tônus uterino normal | d

■ Crise no 3º trim/periparto com HAS → afastar eclâmpsia.

■ PS / Sala — Crise refratária

Diazepam 5mg – 1 cp VO se na maternidade e refratária a outras medidas.

Hipertensão (gestante) · CID O10

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.

SSVV: PA ___/___ (repetir), FC ___.

Edema [___], reflexos [normo/hiperativos], [clônus]. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___ cm | tônus uterino norma

■ Sinais de pré-eclâmpsia grave: cefaleia, escotomas, dor em HD/epigástrio, hiper-reflexia.

■ PS / Sala — Hipertensão aguda grave

Nifedipino 20mg – 1 cp VO de 30/30 min.

Hidralazina 5mg – 1 amp EV de 30/30 min.

■ PS / Sala — Crise hipertensiva / eclâmpsia (MgSO4)

MgSO4 8ml + SF 0,9% 92ml – correr em 20 min em BIC (300ml/h).

MgSO4 10ml + SG 5% 500ml – correr 100ml/h em BIC.

■ Casa — Crônica / leve

Metildopa 250mg

Tomar 1 a 2 comprimidos VO até de 6/6h.

ITU / Cistite (gestante) · CID O23

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., afebril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Abdome gravídico; dor suprapúbica leve. Giordano negativo bilateral. [Se Giordano+ ou febre → pielonefrite]

■ Casa — Prescrição — Casa

<36 semanas: Nitrofurantoína 100mg – 1 cp VO de 6/6h por 5 dias.

>36 semanas: Cefalexina 500mg – 1 cp VO de 6/6h por 7 dias.

Amoxicilina ou Amoxicilina + clavulanato – de 8/8h por 4–7 dias.

Náuseas e vômitos (gestante) · CID O21

Exame físico

BEG, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril., hidratada.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Abdome gravídico, indolor, RHA+. Sem sinais de desidratação. [IG ___ sem; avaliar cetose/hiperêmese se vômitos]

■ Casa — Prescrição — Casa

Ondansetrona (Vonau, Zofran) 4mg – 1 cp VO de 8/8h.

OU Meclizina (Meclin) 25mg – 1 cp VO de 8/8h.

OU Metoclopramida (Plasil) 4mg – 1 cp/1 amp de 8/8h.

OU Dimenidrinato (Dramin) 40 gotas/1cp/1 amp de 8/8h.

OU Ranitidina 150mg – 1 cp VO de 8/8h.

Pielonefrite (gestante) · CID O23

Exame físico

REG, febril.

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Giordano POSITIVO à [D/E]. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___ cm | tônus uterino normal | dinâmica ausente | se

Alto risco de trabalho de parto prematuro/sepse → internar.

■ Internação — Prescrição — Internação

Cefuroxima 750mg EV de 8/8h – até ficar afebril e trocar por VO, completando 10–14 dias.

OU Cefepima 2g EV de 8/8h ou de 12/12h.

Pneumonia / Sinusite / Amigdalite (gestante) · CID J18 · J01 · J03

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril., [febril].

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Foco: [AP com estertores / orofaringe com exsudato / dor em seios da face]. SatO2 ___%. Obstétrico: BCF ___ bpm

■ Casa — Prescrição — Casa

Amoxicilina 500mg – 1 cp VO de 8/8h.

OU Amoxicilina + clavulanato (Clavulin) 875+125mg – 1 cp VO de 12/12h.

OU Azitromicina 500mg – 1 cp VO 1x ao dia por 5 dias.

Prurido (gestante) · CID L29

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.

Pele: [lesões urticariformes / sem lesões]. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___ cm | tônus uterino normal | dinâmica

■ Prurido palmoplantar sem lesões no 3º trim → afastar colestase gravídica (dosar ácidos biliares/TGO/TGP)

■ Casa — Prescrição — Casa

Levocetirizina (Zina) 5mg – 1 cp VO.

OU Loratadina 10mg – 1 cp VO.

OU Hidroxizina (Hixizine) 25mg – 1 cp VO.

OU Fexofenadina (Allegra) 120mg – 1 cp VO.

Síndrome gripal (gestante) · CID J06

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril., [febril].

SSVV: PA ___/___ | FC ___ | FR ___ | SatO2 ___% | Tax ___°C.

Orofaringe hiperemiada, coriza. AP: MV+ sem RA, SatO2 preservada. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___ cm | tônus

Gestante é grupo de risco para influenza – baixo limiar para oseltamivir.

■ Casa — Prescrição — Casa

Beclometasona spray nasal – 2 jatos em cada narina de 12/12h.

OU Budesonida spray nasal – 2 jatos em cada narina de 12/12h.

Bromelín S – 10ml de 12/12h.

Loratadina 10mg – 1 cp VO 1x ao dia.

Tricomoníase (gestante) · CID A59

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.
Especular: corrimento amarelo-esverdeado bolhoso, colo 'em framboesa', pH >4,5, teste de aminos +. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___

■ Casa — Prescrição — Casa

Metronidazol 250mg – 2 cp de 12/12h por 7 dias.
OU Metronidazol 250mg – 8 cp VO dose única.

Vaginose (gestante) · CID N76

Exame físico

BEG, corada, hidratada, acianótica, anictérica, afebril.
Especular: corrimento acinzentado homogêneo, odor de peixe (aminas +), pH >4,5. Obstétrico: BCF ___ bpm | AU ___
Associada a parto prematuro – tratar.

■ Casa — Prescrição — Casa

Metronidazol vaginal – 1 dosador 1x à noite por 5 dias.

■ **NÃO usar em gestante**

■ **NÃO prescrever em gestantes:** AINEs · Sulfametoxazol + trimetoprima · Valproato de sódio (epilepsia).

■ Lista de contraindicações frequentes. Sempre checar categoria de risco na gestação antes de prescrever.

■ **Modelos / Bônus**

Conduta / Alta

■ Modelo — Modelo

Medicação na unidade + conduta para casa.
Orientações gerais. Oriente sinais de alarme. Prescrevo sintomáticos.
Explico o uso correto das medicações. Oriente retorno caso haja sinal de alarme ou piora.
Converso com o paciente e esclareço dúvidas. Explico a conduta aplicada; o paciente aceita, entende e concorda.
Alta médica.

Exame físico — frases direcionadas

■ Modelo — Geral (resumido)

Bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril.
Murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, sem ruídos adventícios, eupneico em ar ambiente.
BRNF 2T, sem sopros, pulsos cheios, TEC <2s.
Abdome flácido, plano, indolor à palpação.
Membros: sem edema, sem dor à palpação, sem sinais de TVP, TEC <3s, pulsos amplos e simétricos.
Neuro: Glasgow 15, sem sinais meníngeos, sem déficits focais.

■ Modelo — ORL / Pescoço / Oroscoopia

Oroscoopia: sem evidências de hiperemia, adenomegalias, abaulamentos patológicos, placas ou exsudatos.
Pescoço: traqueia centrada, musculatura tópica, sem alterações cutâneas à inspeção, ausência de massas ou tumores.
Orofaringe sem alterações à inspeção, sem linfonodomegalia cervical.
Orofaringe com discreta hiperemia e edema, sem exsudato. Ausência de linfonodomegalia cervical palpável.
Orofaringe com amígdalas hiperemiadas e hipertrofiadas, com exsudato puntiforme esbranquiçado. Sem linfonodomegalia palpável.

■ Modelo — Otoscopia

Otoscopia normal: coloração perolácea, íntegra, triângulo luminoso de Politzer presente, impressão do cabo de violão presente.
Otite média aguda: MT hiperemiada, abaulada, perfuração puntiforme com saída de secreção purulenta.
OD: MT com discreta opacidade, sem abaulamento, sem perfuração.
Cerume: massa marrom/amarelada em forma de rolha, pode impossibilitar a visualização da MT.
Otite externa: MT normal, secreção e edema no conduto auditivo externo.

■ Modelo — Oftalmo / Ombro / Coluna / Toque retal

Olho esquerdo: hiperemia conjuntival difusa, secreção serosa/aquosa discreta, sem secreção purulenta, sem exsudato.
Ombro: sem sinais flogísticos, discreta limitação por dor, sem deformidades, neurovascular distal preservada.
Coluna lombar discretamente dolorosa à palpação paravertebral, sem deformidades, mobilidade preservada, sem limitação.
Cervicalgia com contratura muscular, dor à palpação e limitação de mobilidade, sem déficits neurológicos.
Anoperíneo/toque retal: pele e mucosa íntegras, esfíncter normotenso, sem tumorações, fezes em ampola retal.

■ Modelo — Resumo — antecedentes

#Medicamentos de uso contínuo: nega
#Comorbidades prévias: nega
#Alergias: nega alergias medicamentosas conhecidas.
#Tabagista:
#Gestante:

Medicações na unidade (IM / EV)

■ PS / Sala — Analgésicos / AINE / corticoide

Cetoprofeno 50mg/mL (2mL) – aplicar 1 amp IM agora.
Dipirona sódica 500mg/mL (2mL) – aplicar 1 amp IM agora.
Dexametasona 4mg/mL – aplicar 1 amp IM agora.
Diclofenaco sódico 25mg/mL (3mL) – aplicar 1 amp IM agora.

■ PS / Sala — Sintomáticos (náusea / vômito / gástrico)

Ondansetrona 2mg/mL – aplicar 1 amp IM agora.
Bromoprida 5mg/mL (2mL) – aplicar 1 amp IM agora.
Metoclopramida 5mg/mL (2mL) – aplicar 1 amp IM agora.
Dimenidrinato + piridoxina 50+50mg/mL (1mL) [Dramin B6] – aplicar 1 amp IM profundo agora.
Omeprazol 40mg (pó liofilizado) – diluir em 10mL do diluente próprio e fazer EV lento agora.

■ PS / Sala — Antiespasmódicos

Escopolamina simples 20mg/mL (1mL) [Buscopan] – aplicar 1 amp IM agora.
Escopolamina + dipirona [Buscopan composto] – aplicar 1 amp IM agora.

■ PS / Sala — Opioides (dor forte / refratária)

Tramadol 50mg (1mL): 1 amp + SF 0,9% 100mL EV, correr lento em 20 minutos.
Morfina 10mg/mL (1mL) EV diluída: diluir 1 amp (1mL) + 9mL AD (=1mg/mL); aplicar ____ mL (____ mg) EV lento a ____ mL (____ mg) EV rápido.
Morfina 10mg/mL (1mL) IM pura: aplicar ____ mL IM profundo agora (0,3 a 0,5 mL para analgesia).

■ PS / Sala — Outros

Prometazina 25mg/mL (2mL) [Fenergan] – aplicar 1 amp IM profundo agora.
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI [Benzetacil] – diluir com 4mL AD, aplicar 1 F/A IM profundo agora.

■ Formulário SUS

Formulário SUS — A

■ 29 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (A)

abacavir, sulfato (ABC) 20 mg/mL solução oral – disp. em SAE/IST/AIDS
abacavir, sulfato (ABC) 300 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
aciclovir 30 mg/g (3%) pomada oftálmica – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes em tratamento de herpes zoster
aciclovir 50 mg/g (5%) creme – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes em tratamento de herpes zoster
aciclovir 200 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
aciclovir 400 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS · Exclusivamente para pacientes em tratamento destas doenças
ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
ácido fólico 0,2 mg/mL solução oral (gotas) – disp. nas Unidades de Saúde
ácido fólico 5 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
ácido folínico 5 mg/mL solução oral – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes em tratamento de anemia megaloblástica
ácido paraminossalicílico 4g sachê granulado revestido – disp. em unidades de referência - exclusivo para pacientes com doença inflamatória intestinal
adapaleno 1 mg/g (0,1%) gel – disp. nas Unidades de Saúde
albendazol 40 mg/mL suspensão oral – disp. nas Unidades de Saúde
albendazol 400 mg comprimido mastigável – disp. nas Unidades de Saúde
alendronato de sódio 70 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde · Exclusivamente para o tratamento da osteoporose
alfapectinterferona 2A 180 mcg seringa preenchida – disp. em unidades de referência para tratamento de hepatite crônica
algestona acetofenida 150 mg/mL + enantato de estradiol 10 mg/mL solução injetável – disp. nas Unidades de Saúde
alopurinol 100 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
amiodarona, cloridrato 200 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
amitriptilina, cloridrato 25 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
amoxicilina 50 mg/mL pó para suspensão oral – disp. nas Unidades de Saúde
amoxicilina 500 mg cápsula – disp. nas Unidades de Saúde
anlodipino, besilato 5 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
anlodipino, besilato 10 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
atazanavir, sulfato (ATV) 300 mg cápsula – disp. em SAE/IST/AIDS
atenolol 50 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
atorvastatina 10 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS · Exclusivamente para pacientes em tratamento nesta condição
azitromicina 40 mg/mL suspensão oral – disp. nas Unidades de Saúde
azitromicina 500 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde

Formulário SUS — B

■ 9 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (B)

beclometasona, dipropionato 50 mcg/dose pó, solução inalante ou aerossol oral – disp. nas Unidades de Saúde
beclometasona, dipropionato 200 mcg/dose aerossol oral – disp. nas Unidades de Saúde
beclometasona, dipropionato 50 mcg/dose aerossol nasal – disp. nas Unidades de Saúde
benzilpenicilina benzatina 600.000 UI pó para suspensão injetável fam – disp. nas Unidades de Saúde
benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI pó para suspensão injetável fam – disp. nas Unidades de Saúde
benzoilmetronidazol 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) suspensão oral ou secnidazol 30 mg/mL suspensão oral
biperideno, cloridrato 2 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
brimonidina 2 mg/mL (0,2%) solução oftálmica – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes com glaucoma
bupropiona, cloridrato 150 mg comprimido – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes com depressão

Formulário SUS — C

■ 36 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (C)

cabergolina 0,5 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS · Exclusivamente para pacientes em tratamento nestas
captopril 25 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
carbamazepina 20 mg/mL (2%) suspensão oral – disp. nas Unidades de Saúde
carbamazepina 200 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
carbonato de cálcio 1.250 mg (equivalente a 500 mg de Ca++) comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
carbonato de cálcio 1.500 mg (equivalente a 600 mg de Ca++) + colecalciferol (vit D3) 400 UI comprimido –
carbonato de lítio 300 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
carvedilol 6,25 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
carvedilol 12,5 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
cefalexina 50 mg/mL suspensão oral – disp. nas Unidades de Saúde
cefalexina comprimido 500 mg – disp. nas Unidades de Saúde
cetoconazol 20 mg/g (2%) creme – disp. nas Unidades de Saúde
cetoconazol 2% shampoo – disp. nas Unidades de Saúde
cianocobalamina (vit. B12) 2,5 mg/mL (2.500 mcg) solução injetável – disp. nas Unidades de Saúde
ciprofloxacino, cloridrato 500 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
ciproterona 50 mg comprimido – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes cadastrados
claritromicina 50 mg/mL pó para suspensão oral – disp. nas Unidades de Saúde
claritromicina 500 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde e em unidades de referência para tratamento
clindamicina, cloridrato 300 mg cápsula – disp. nas Unidades de Saúde
clofazimina 100 mg comprimido – disp. em unidades de referência - exclusivo para tratamento de esquemas es
clofazimina 100 mg + clofazimina 50 mg + rifampicina 300 mg + dapsona 100 mg (multibacilar) adulto comprimi
clofazimina 150 mg + clofazimina 50 mg + rifampicina 300 mg + rifampicina 150 mg + dapsona 50 mg (multibaci
clomipramina, cloridrato 25 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
clonazepam 2,5 mg/mL (0,25%) solução oral gotas – disp. nas Unidades de Saúde
clonazepam 0,5 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
clonazepam 2 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
cloranfenicol 5 mg/g + retinol, acetato 10.000 UI/g + aminoácidos 25 mg/g + metionina 5 mg/g pomada oftálmic
cloreto de sódio 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL) solução injetável ampola – disp. nas Unidades de Saúde
cloreto de sódio 9 mg/mL (0,9%) solução nasal gotas – disp. nas Unidades de Saúde
clorpromazina, cloridrato 40 mg/mL (4%) solução oral (gotas) – disp. nas Unidades de Saúde
clorpromazina, cloridrato 25 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
clorpromazina, cloridrato 100 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
colecalciferol (vitamina D3) 200 UI a 220 UI/gota solução oral – disp. em unidades de referência
Dispensação sob protocolo (em elaboração)
Cynara scolymus L. (alcachofra) 24 a 48 mg derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico
Orientação técnica para prescrição e dispensação

Formulário SUS — D

■ 20 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (D)

daclatasvir 60 mg comprimido – disp. em unidades de referência para tratamento de hepatites virais · Exclu
dapsona 100 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
darunavir (DRV) 75 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
darunavir (DRV) 150 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
darunavir (DRV) 600 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
darunavir (DRV) 800 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
dexametasona 0,1 mg/mL solução oral – disp. nas Unidades de Saúde
dexametasona 1 mg/g (0,1%) creme – disp. nas Unidades de Saúde
dexametasona 1 mg/mL (0,1%) suspensão oftálmica – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pa
dexclorfeniramina, maleato 0,4 mg/mL solução oral – disp. nas Unidades de Saúde
dextrana 1 mg/mL + hipromelose 3 mg/mL (0,3%) solução oftálmica – disp. nas Unidades de Saúde
diazepam 5 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
diclofenaco 50 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
digoxina 0,25 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
dimenidrinato 25 mg/mL + piridoxina, cloridrato (vit. B6) 5 mg/mL solução oral gotas – disp. nas Unidades
dipirona sódica 500 mg/mL solução oral gotas – disp. nas Unidades de Saúde
dipirona sódica 500 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
dolutegravir 50 mg (DTG) comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
doxazosina 2 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
doxiciclina, cloridrato 100 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde

Formulário SUS — E

■ 26 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (E)

efavirenz (EFZ) 30 mg/mL solução oral – disp. em SAE/IST/AIDS
efavirenz (EFZ) 200 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
efavirenz (EFZ) 600 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
enalapril, maleato 5 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
enalapril, maleato 20 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde

enfuvirtida (T-20) 90 mg/mL pó para solução injetável – disp. em SAE/IST/AIDS
enoxaparina sódica 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) solução injetável seringa 0,2 mL SC – disp. em unidades
Dispensação exclusiva para usuários em tratamento na Rede Municipal de Saúde – Necessário formulário para
enoxaparina sódica 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) solução injetável seringa 0,4 mL SC – disp. em unidades
Dispensação exclusiva para usuários em tratamento na Rede Municipal de Saúde – Necessário formulário para
enoxaparina sódica 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) solução injetável seringa 0,6 mL SC – disp. em unidades
Dispensação exclusiva para usuários em tratamento na Rede Municipal de Saúde – Necessário formulário para
entecavir 0,5 mg comprimido – disp. em unidades de referência para tratamento de hepatites virais · Exclusiv
escopolamina 10 mg/mL solução oral gotas ou comprimido 10 mg – disp. nas Unidades de Saúde
escopolamina 6,67 mg/mL + dipirona sódica 333,4 mg/mL solução oral gotas – disp. nas Unidades de Saúde
espiramicina 500 mg (equivalente a 1.500.000 UI) comprimido – disp. em unidades de referência · Exclusivam
espironolactona 25 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
espironolactona 100 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
estradiol, valerato 1mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
estradiol, valerato 2mg comprimido – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes cadas
estriol 1 mg/g (0,1%) creme vaginal – disp. nas Unidades de Saúde
etambutol, cloridrato 400 mg comprimido – disp. em unidades de referência - exclusivo para tratamento de e
etionamida 250 mg comprimido – disp. em unidades de referência - exclusivo para tratamento de esquemas esp
etonogestrel 68 mg implante subdérmico – disp. em unidades de referência · Necessário formulário para proc
etravirina (ETR) 100 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
etravirina (ETR) 200 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS

Formulário SUS — F

■ 12 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (F)

fenitoína ou fenitoína sódica 100 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
fenobarbital 100 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
fenobarbital 40 mg/mL (4%) solução oral gotas – disp. nas Unidades de Saúde
fenoterol 5 mg/mL solução inalante gotas – disp. nas Unidades de Saúde
finasterida 5 mg comprimido – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes em tratament
fluconazol 100 mg cápsula – disp. em SAE/IST/AIDS · Exclusivamente para pacientes em tratamento nestas uni
fluconazol 150 mg cápsula – disp. nas Unidades de Saúde
fluoxetina, cloridrato 20 mg cápsula – disp. nas Unidades de Saúde
folinato de cálcio 15 mg comprimido – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes em t
formoterol 6 mcg + budesonida 200 mcg pó em cápsula para inalação – disp. nas Unidades de Saúde · Exclusiv
formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg pó em cápsula para inalação – disp. nas Unidades de Saúde · Exclusi
furosemida 40 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde

Formulário SUS — G

■ 4 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (G)

gabapentina 300 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS · Exclusivamente para pacientes em tratamento nestas
gliclazida 60 mg comprimido de liberação prolongada – disp. nas Unidades de Saúde
Glycine max (L.) Merrill. (isoflavonas de soja) mínimo de 50 mg de isoflavonas totais – disp. nas Unidades
Orientação técnica para prescrição e dispensação

Formulário SUS — H

■ 11 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (H)

haloperidol 2 mg/mL (0,2%) solução oral gotas – disp. nas Unidades de Saúde
haloperidol 1 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
haloperidol 5 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
haloperidol, decanoato 70,52 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de haloperidol) solução injetável – disp. nas U
Harpagophytum procumbens (Burch.) DC. (garra do diabo) harpagosídeo 5 mg a 50 mg comprimido – disp. nas Un
Orientação técnica para prescrição e dispensação
hidroclorotiazida 25 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
hidrocortisona, acetato 10 mg/g (1%) creme – disp. nas Unidades de Saúde
hidróxido de alumínio 60 mg/mL a 63 mg/mL suspensão oral – disp. nas Unidades de Saúde
hipoclorito de sódio 25 mg/mL de cloro ativo (2,5 %) solução
disponível nas Unidades de Saúde

Formulário SUS — I

■ 29 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (I)

ibuprofeno 50 mg/mL suspensão oral gotas – disp. nas Unidades de Saúde
ibuprofeno 300 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
imipramina, cloridrato 25 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
imiquimode 50 mg/g (5%) creme – disp. em SAE/IST/AIDS · Exclusivamente para pacientes em tratamento nestas
imunoglobulina anti Rho (D) 250 mcg a 300 mcg solução injetável fam – disp. em unidades de referência
Exclusivo para procedimento

imunoglobulina humana anti-hepatite B 1000 UI/ 5 mL solução injetável – disp. em unidades de referência para
insulina humana NPH 100 UI/mL suspensão injetável frasco – disp. nas Unidades de Saúde
insulina humana NPH 100 UI/mL suspensão injetável caneta – disp. nas Unidades de Saúde
Orientação técnica para prescrição e dispensação – Necessário formulário para dispensação
Insulina humana NPH 100 UI/mL suspensão injetável carpule / tubete – disp. nas Unidades de Saúde
Orientação técnica para prescrição e dispensação – Necessário formulário para dispensação
insulina humana regular 100 UI/mL solução injetável frasco – disp. nas Unidades de Saúde
insulina humana regular 100 UI/mL solução injetável caneta – disp. nas Unidades de Saúde
Orientação técnica para prescrição e dispensação – Necessário formulário para dispensação
insulina humana regular 100 UI/mL solução injetável carpule / tubete – disp. nas Unidades de Saúde
Orientação técnica para prescrição e dispensação – Necessário formulário para dispensação
ipratrópio, brometo 0,25 mg/mL (0,025%) solução inalante gotas – disp. nas Unidades de Saúde
isoniazida 100 mg comprimido – disp. em unidades de referência - medicamento exclusivo para tratamento de
isoniazida 300 mg comprimido
medicamento utilizado no tratamento de ILTB em unidades IST/Aids; tratamento de ILTB, associado a rifapentina
isoniazida 150 mg + rifampicina 300 mg comprimido
medicamento exclusivo para tratamento com esquema básico de TB nas Unidades de Saúde; tratamento de esquema
isoniazida 75 mg + rifampicina 150 mg comprimido
medicamento exclusivo para tratamento com esquema básico de TB nas Unidades de Saúde; tratamento de esquema
isossorbida, dinitrato 5 mg comprimido sublingual ou propatilnitrato 10 mg comprimido – disp. nas Unidades de
isossorbida, mononitrato 20 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
itraconazol 100 mg cápsula – disp. nas Unidades de Saúde
ivermectina 6 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde

Formulário SUS — L

■ 24 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (L)

lamivudina (3TC) 10 mg/mL solução oral – disp. em SAE/IST/AIDS
lamivudina (3TC) 150 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
levodopa 100 mg + benserazida 25 mg cápsula de liberação prolongada (HBS) – disp. em unidades de referência
levodopa 100 mg + benserazida 25 mg comprimido – disp. em unidades de referência
levodopa 100 mg + benserazida 25 mg comprimido dispersível – disp. em unidades de referência
levodopa 200 mg + benserazida 50 mg comprimido – disp. em unidades de referência
levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg comprimido – disp. em unidades de referência
levofloxacino 250 mg comprimido – disp. em unidades de referência - exclusivo para tratamento de esquemas
levofloxacino 500 mg comprimido – disp. em unidades de referência - exclusivo para tratamento de esquemas
levonorgestrel 0,75 mg comprimido cartela – disp. nas Unidades de Saúde
levonorgestrel 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 mg comprimido cartela – disp. nas Unidades de Saúde
levonorgestrel 19,5 mg sistema intrauterino (SIU) – disp. em unidades de referência · Necessário formulário
levonorgestrel 52 mg sistema intrauterino (SIU) – disp. em unidades de referência · Necessário formulário
levotiroxina sódica 12,5 mcg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
levotiroxina sódica 25 mcg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
levotiroxina sódica 50 mcg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
levotiroxina sódica 100 mcg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
linezolid 600 mg comprimido – disp. em unidades de referência - exclusivo para tratamento de esquemas esp
loperamida 2 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS · Exclusivamente para pacientes em tratamento nestas un
lopinavir (LPV) 80 mg/mL + ritonavir (r) 20 mg/mL solução oral – disp. em SAE/IST/AIDS
lopinavir (LPV) 100 mg + ritonavir (r) 25 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
loratadina 1 mg/mL solução oral – disp. nas Unidades de Saúde
loratadina 10 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
losartana potássica 50 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde

Formulário SUS — M

■ 21 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (M)

maraviroque (MVQ) 150 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
Maytenus ilicifolia Mart. ex. Reissek. (espíndula) taninos totais 13 mg a 20 mg comprimido – disp.
Orientação técnica para prescrição e dispensação
mebendazol 20 mg/mL suspensão oral – disp. nas Unidades de Saúde
medroxiprogesterona, acetato 10 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
medroxiprogesterona, acetato 25 mg + estradiol cipionato 5 mg suspensão injetável – disp. nas Unidades de
medroxiprogesterona, acetato 150 mg/mL suspensão injetável – disp. nas Unidades de Saúde
metformina, cloridrato 500 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
metformina, cloridrato 850 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
metildopa 250 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
metilfenidato 10 mg comprimido – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para os pacientes em tra
Orientação técnica para prescrição
metoclopramida, cloridrato 10 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
metronidazol 100 mg/g (10%) creme ou gel vaginal – disp. nas Unidades de Saúde
metronidazol 250 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
miconazol, nitrato 20 mg/g (2%) creme vaginal – disp. nas Unidades de Saúde
Mikania glomerata spreng (guaco) solução oral – disp. nas Unidades de Saúde · Exclusivamente para paciente
Orientação técnica para prescrição e dispensação

morfina, sulfato 30 mg comprimido de liberação modificada – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para tratamento de esquemas
moxifloxacino 400 mg comprimido – disp. em unidades de referência - exclusivo para tratamento de esquemas
mupirocina 20 mg/g pomada bisnaga – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes em tratamento de lesões de pele

Formulário SUS — N

■ 16 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (N)

naltrexona 50 mg comprimido – disp. em UBS e CAPS AD
nevirapina (NVP) 10 mg/mL suspensão oral – disp. em SAE/IST/AIDS
nevirapina (NVP) 200 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
nicotina 2 mg goma de mascar – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes cadastrados
nicotina 7 mg adesivo transdérmico – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes cadastrados
nicotina 14 mg adesivo transdérmico – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes cadastrados
nicotina 21 mg adesivo transdérmico – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes cadastrados
nifedipino 20 mg comprimido liberação prolongada – disp. nas Unidades de Saúde
nirmatrelvir + ritonavir comprimidos revestidos – disp. em unidades de referência
Exclusivo para tratamento de COVID-19
nistatina 100.000 UI/mL suspensão oral – disp. nas Unidades de Saúde
nitrofurantoina 100 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
noretisterona 0,35 mg comprimido cartela – disp. nas Unidades de Saúde
noretisterona, enantato 50 mg/mL + estradiol, valerato 5 mg/mL solução injetável – disp. nas Unidades de Saúde
norfloxacino 400 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
nortriptilina, cloridrato 25 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde

Formulário SUS — O

■ 6 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (O)

óleo mineral frasco – disp. nas Unidades de Saúde
omeprazol 20 mg cápsula – disp. nas Unidades de Saúde
oseltamivir 30 mg cápsula – disp. nas Unidades de Saúde
oseltamivir 45 mg cápsula – disp. nas Unidades de Saúde
oseltamivir 75 mg cápsula – disp. nas Unidades de Saúde
óxido de zinco 150 a 250 mg/g + retinol (vit. A) + colecalciferol pomada – disp. nas Unidades de Saúde

Formulário SUS — P

■ 23 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (P)

paracetamol 200 mg/mL solução oral gotas – disp. nas Unidades de Saúde
paracetamol 500 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
pentoxifilina 400 mg comprimido – disp. em unidades de referência de Hanseníase
periciazina 40 mg/mL (4%) solução oral gotas – disp. nas Unidades de Saúde
permetrina 10 mg/mL (1%) loção capilar – disp. nas Unidades de Saúde
permetrina 50 mg/mL (5%) creme ou loção – disp. nas Unidades de Saúde
pilocarpina, cloridrato 20 mg/mL (2%) solução oftálmica – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para tratamento de glaucoma
pirazinamida 500 mg comprimido – disp. em unidades de referência - exclusivo para tratamento de esquemas de TB
pirazinamida 150 mg comprimido dispersível – disp. em unidades de referência - exclusivo para tratamento de TB
piridoxina, cloridrato (vit. B6) 40 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde e em unidades de referência
piridoxina, cloridrato (vit. B6) 50 mg comprimido – disp. em unidades de referência - exclusivo para tratamento de TB
pirimetamina 25 mg comprimido – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes em tratamento de TB
pirimetamina 3 mg/mL solução oral – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes em tratamento de TB
pravastatina 20 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS · Exclusivamente para pacientes em tratamento nestas unidades
praziquantel 600 mg comprimido – disp. em unidades de referência, utilizado no tratamento da esquistossomose
prednisolona, fosfato sódico 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) solução oral – disp. nas Unidades de Saúde
prednisona 5 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
prednisona 20 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
primaquina 15 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
progesterona 200 mg cápsula gelatinosa – disp. nas Unidades de Saúde
prometazina, cloridrato 25 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
propiltiuracila 100 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
propranolol, cloridrato 40 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde

Formulário SUS — R

■ 15 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (R)

raltegravir (RAL) 100 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
raltegravir (RAL) 100 mg granulado sachê – disp. em SAE/IST/AIDS
raltegravir (RAL) 400 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS
retinol, acetato (vit. A) 50.000 UI/mL + colecalciferol (vit. D) 10.000 UI/mL solução oral gotas – disp. nas Unidades de Saúde
rifabutina 150 mg cápsula – disp. em unidades de referência - exclusivo para o tratamento de TB para pacientes com HIV
rifampicina 20 mg/mL (2%) suspensão oral – disp. em unidades de referência - exclusivo para tratamento de TB

rifampicina 300 mg cápsula – disp. em unidades de referência - exclusivo para cobertura de foco de meningi
rifampicina 150 mg + isoniazida 75 mg + pirazinamida 400 mg + etambutol, cloridrato 275 mg comprimido
medicamento exclusivo para tratamento de TB nas Unidades de Saúde; tratamento de esquemas especiais de TB e
rifampicina 75 mg + isoniazida 50 mg + pirazinamida 150 mg comprimido dispersível – disp. em unidades de r
rifampicina 75 mg + isoniazida 50 mg comprimido dispersível – disp. em unidades de referência - exclusivo
rifapentina 150 mg comprimido – disp. em unidades de referência - exclusivo para tratamento da Infecção La
risperidona 2 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
ritonavir 100 mg/mL pó para suspensão oral – disp. em SAE/IST/AIDS
ritonavir (RTV) 100 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS

Formulário SUS — S

■ 16 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (S)

saís para reidratação oral pó para solução oral – disp. nas Unidades de Saúde
salbutamol, sulfato 100 mcg/dose aerossol oral frasco – disp. nas Unidades de Saúde
sertralina 50 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
sinvastatina 10 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
sinvastatina 20 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
sinvastatina 40 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
sofosbuvir 400 mg comprimido revestido – disp. em unidades de referência para tratamento de hepatites vira
sofosbuvir 400 mg + velpatasvir 100 mg comprimido revestido – disp. em unidades de referência para tratame
sofosbuvir 400 mg + velpatasvir 100 mg + voxilaprevir 100 mg comprimido revestido – disp. em unidades de r
sofosbuvir 200 mg + velpatasvir 50 mg granulado – disp. em unidades de referência para tratamento de hepat
sulfadiazina 500 mg comprimido – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes em tratam
sulfadiazina 150 mg/mL solução oral – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes em t
sulfametoxazol 40 mg/mL + trimetoprima 8 mg/mL suspensão oral – disp. nas Unidades de Saúde
sulfametoxazol 800 mg + trimetoprima 160 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
sulfato ferroso heptahidratado 125 mg/mL (equivalente a 25 mg de Fe++) solução oral gotas – disp. nas Unid
sulfato ferroso heptahidratado equivalente a 40 mg de Fe++ comprimido – disp. nas Unidades de Saúde

Formulário SUS — T

■ 16 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (T)

talidomida 100 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS e em unidades de referência em hanseníase
tenofovir 300 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS e em unidades de referência para tratamento de hepatit
tenofovir alafenamida 25 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS e em unidades de referência para tratamento
tenofovir (TDF) 300 mg + lamivudina (3TC) 300 mg + efavirenz (EFZ) 600 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AI
tenofovir (TDF) 300 mg + entricitabina (FTC) 200 mg – disp. em SAE/IST/AIDS
tenofovir (TDF) 300 mg + lamivudina (3TC) 300 mg – disp. em SAE/IST/AIDS e em unidades de referência para
teofilina 100 mg cápsula de liberação prolongada – disp. nas Unidades de Saúde
terbinafina 250 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
terizidona 250 mg comprimido – disp. em unidades de referência - exclusivo para tratamento de esquemas esp
testosterona, undecanoato 250 mg/mL solução injetável – disp. em unidades de referência · Exclusivamente p
tiamazol 5 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
tiamina, cloridrato (vit. B1) 300 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
timolol, maleato 5 mg/mL (0,5%) solução oftálmica – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para
tinidazol 500 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
tobramicina 3 mg/mL (0,3%) solução oftálmica – disp. nas Unidades de Saúde
tramadol 50 mg comprimido – disp. em unidades de referência · Exclusivamente para pacientes em tratamento

Formulário SUS — U

■ 2 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (U)

ureia 100 mg/g (10%) creme
medicamento para pacientes em tratamento nas unidades de hanseníase

Formulário SUS — V

■ 7 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (V)

valaciclovir 500 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS · Exclusivamente para pacientes em tratamento nesta
Valeriana officinalis L. (valeriana) sesquiterpenos 0,8 mg a 3,5 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saú
Orientação técnica para prescrição e dispensação
valproato de sódio 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg de ácido valpróico) solução oral ou xarope – disp. na
valproato de sódio 576 mg (equivalente a 500 mg de ácido valpróico) comprimido revestido ou cápsula – disp
varfarina sódica 2,5 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde
varfarina sódica 5 mg comprimido – disp. nas Unidades de Saúde

Formulário SUS — Z

■ 4 itens. Consulta de disponibilidade na rede (não é prescrição).

■ Modelo — Medicamentos (Z)

zidovudina (AZT) 10 mg/mL solução injetável – disp. em SAE/IST/AIDS

zidovudina (AZT) 10 mg/mL solução oral – disp. em SAE/IST/AIDS

zidovudina (AZT) 100 mg cápsula – disp. em SAE/IST/AIDS

zidovudina (AZT) 300 mg + lamivudina (3TC) 150 mg comprimido – disp. em SAE/IST/AIDS